ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

HÉMATO-ONCOLOGÍA

90 preguntas de práctica

Hemostasia

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Hémato-oncología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES					
1.08.1.001	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q1, Q2, Q3, Q15, Q16	Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5)
1.08.1.002	Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14	Tomo 08 · 8.2 (Pág. 7)
1.08.1.008	Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q17, Q18	Tomo 08 · 8.5 (Pág. 17)
1.08.1.015	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q4	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.1.016	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q5	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.1.017	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q6	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.008	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q7	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
BLOQUE 2: ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS					
1.08.1.003	Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q19, Q20, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36	Tomo 08 · 8.7 (Pág. 26)
1.08.1.004	Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28	Tomo 08 · 8.6 (Pág. 22)
BLOQUE 3: HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS					
1.08.1.005	Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q39, Q40, Q50, Q51	Tomo 08 · 8.11 (Pág. 39)
1.08.1.006	Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q44, Q45, Q46, Q47, Q48	Tomo 08 · 8.13 (Pág. 45)
1.08.1.012	Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q41, Q42, Q43	Tomo 08 · 8.12 (Pág. 41)
1.08.1.013	Púrpuras vasculares	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.001	Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q53, Q54	Tomo 08 · 8.15 (Pág. 51)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.08.2.002	Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q52	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.003	Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q49	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.009	Trombopenia severa	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
BLOQUE 4: ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES					
1.08.1.007	Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66, Q67, Q68, Q69	Tomo 08 · 8.19 (Pág. 66)
1.08.1.009	Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q55, Q56, Q57, Q58, Q59	Tomo 08 · 8.16 (Pág. 56)
1.08.1.010	Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q60, Q61, Q62	Tomo 08 · 8.17 (Pág. 60)
1.08.1.011	Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q63, Q64, Q65	Tomo 08 · 8.18 (Pág. 62)
1.08.1.018	Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70, Q71, Q72	Tomo 08 · 8.20 (Pág. 68)
BLOQUE 5: URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL					
1.08.1.014	Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q88	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.1.019	Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q84, Q85, Q86, Q87	Tomo 08 · 8.23 (Pág. 79)
1.08.2.004	Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q76, Q77	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.005	Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q78, Q79, Q80, Q81, Q82	Tomo 08 · 8.22 (Pág. 77)
1.08.2.006	Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q73, Q74, Q75	Tomo 08 · 8.21 (Pág. 73)
1.08.2.007	Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q83	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.3.005	Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q89, Q90	Tomo 08 · 8.24 (Pág. 81)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Hémato-oncología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.08.1.001	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q1, Q2, Q3, Q15, Q16	Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5)
1.08.1.002	Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14	Tomo 08 · 8.2 (Pág. 7)
1.08.1.003	Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q19, Q20, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36	Tomo 08 · 8.7 (Pág. 26)
1.08.1.004	Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28	Tomo 08 · 8.6 (Pág. 22)
1.08.1.005	Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q39, Q40, Q50, Q51	Tomo 08 · 8.11 (Pág. 39)
1.08.1.006	Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q44, Q45, Q46, Q47, Q48	Tomo 08 · 8.13 (Pág. 45)
1.08.1.007	Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66, Q67, Q68, Q69	Tomo 08 · 8.19 (Pág. 66)
1.08.1.008	Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q17, Q18	Tomo 08 · 8.5 (Pág. 17)
1.08.1.009	Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q55, Q56, Q57, Q58, Q59	Tomo 08 · 8.16 (Pág. 56)
1.08.1.010	Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q60, Q61, Q62	Tomo 08 · 8.17 (Pág. 60)
1.08.1.011	Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q63, Q64, Q65	Tomo 08 · 8.18 (Pág. 62)
1.08.1.012	Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q41, Q42, Q43	Tomo 08 · 8.12 (Pág. 41)
1.08.1.013	Púrpuras vasculares	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.1.014	Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q88	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.1.015	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q4	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.08.1.016	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q5	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.1.017	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q6	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.1.018	Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70, Q71, Q72	Tomo 08 · 8.20 (Pág. 68)
1.08.1.019	Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q84, Q85, Q86, Q87	Tomo 08 · 8.23 (Pág. 79)
1.08.2.001	Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q53, Q54	Tomo 08 · 8.15 (Pág. 51)
1.08.2.002	Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q52	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.003	Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q49	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.004	Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q76, Q77	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.005	Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q78, Q79, Q80, Q81, Q82	Tomo 08 · 8.22 (Pág. 77)
1.08.2.006	Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q73, Q74, Q75	Tomo 08 · 8.21 (Pág. 73)
1.08.2.007	Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q83	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.008	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q7	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.009	Trombopenia severa	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.3.005	Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q89, Q90	Tomo 08 · 8.24 (Pág. 81)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

PREGUNTA 1 1.08.1.001

1. **Una paciente de 52 años, con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento per- manente con AINES y prednisona por vía oral y tratamiento intermitente con metotre- xate por vía oral, presenta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos que ha empeorado en el último tiempo. Se solicitan exámenes en los que destacan una creatini- na de 1,6mg/dL, hemograma con hematocrito 29%, hemoglobina 9,7g/dL, plaquetas 147.000/mm3, blancos 4.200/mm3 y al frotis se aprecia microcitosis. Además se solicita perfil de fierro que muestra ferremia de 40ug/dL (60-160 ug/dL) y transferrina de 190mg/dL (240-360mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Anemia por enfermedades crónicas
B) Mielodisplasia
C) Anemia por insuficiencia renal crónica
D) Hipoplasia medular
E) Mieloma múltiple

PREGUNTA 2 1.08.1.001

2. **900 x mm3, VCM: 106 ft, HCM: 32 pg, VHS: 32 mm/h. Al frotis sólo destacan plaquetas disminuidas y macrocitosis leve. Al examen físico no se detectan otras alteraciones. La conducta más adecuada es:**

A) Solicitar biopsia de médula ósea
B) Iniciar vitamina 12 y folatos
C) Iniciar sulfato ferroso
D) Solicitar niveles plasmáticos de homocisteína
E) Solicitarde Coombs directo y haptoglobinayoncologia/ 4/6

PREGUNTA 3 1.08.1.001

3. **Un paciente con anemia normocítica normocrómica, se realiza exámenes que demuestran índice reticulocitario bajo, ferritina baja, ferremia baja y transferrina muy elevada. El diagnóstico más probable es:**

A) Mielodisplasia
B) Anemia de enfermedades crónicas
C) Anemia ferropénica
D) Hemocromatosis
E) Anemia hemolítica

PREGUNTA 4 1.08.1.015

4. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome leucoeritroblástico · 1.08.1.015] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome leucoeritroblástico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 5 1.08.1.016

5. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome paraneoplásico · 1.08.1.016] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome paraneoplásico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 6 1.08.1.017

6. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndromes mielodisplásicos · 1.08.1.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndromes mielodisplásicos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 7 1.08.2.008

7. Un paciente de 75 años, con diagnóstico de cáncer de células pequeñas, presenta un cuadro de 2 días de aumento de volumen de la cara, asociado a confusión mental y tos. Al examen físico está desorientado, tiene eritema y cianosis de la cara y se observa dilatación de las venas del cuello. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar resonancia magnética nuclear de tórax
B) Administrar diuréticos por vía endovenosa
C) Realizar quimioterapia de urgencia
D) Realizar radioterapia de urgencia
E) Realizar broncoscopía de urgencia

PREGUNTA 8 1.08.1.002

8. Una paciente de 19 años, con antecedentes de sangrado menstrual abundante desde su menarquia a los 12 años y de una cirugía de by pass gástrico realizado hace un año, consulta por un cuadro de disnea e intolerancia al ejercicio, de 4 meses de evolución, que ha ido en aumento. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con hemoglobina: 9,1 g/dl, hematocrito 28%, blancos: 6.200 por mm3, plaquetas 300.000 por mm3; ferritina plasmática: 9 ng/ml (VN: 12 – 150 ng/ml) y saturación de transferrina 12%. La conducta más adecuada es:

A) Indicar hierro por vía oral
B) Administrar hierro por vía endovenosa
C) Administrar folatos orales
D) Administrar vitamina B12 por vía intra muscular
E) Transfundir glóbulos rojos

PREGUNTA 9 1.08.1.002

9. La ferropénica se caracteriza por presentar:

A) Ferritina disminuida y transferrina elevada
B) Ferritina aumentada y transferrina disminuida
C) Ferritina y transferrina aumentadas
D) Ferritina y transferrina disminuidas
E) Ferritina y transferrina dentro de rangos normales

PREGUNTA 10 1.08.1.002

10. La anemia ferropénica se caracteriza por presentar

A) Elevación de la ferritina y de la transferrina
B) Elevación de la transferrina y disminución de la ferritina
C) Elevación de la ferritina y disminución de la transferrina
D) Disminución de la ferritina y de la transaferrina
E) Disminución de la ferritina, aumento de la ferremia y disminución de la saturación de la tranferrina

PREGUNTA 11 1.08.1.002

11. Una paciente de 28 años se encuentra en su quinto día postparto, tras el cual presentó atonía uterina que se manejó farmacológicamente. En el examen físico, presenta palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 8.6 g/dL y hematocrito: 25%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar hierro por vía oral
B) Administrar hierro por vía endovenosa
C) Realizar una transfusión de glóbulos rojos
D) Administrar un uterotónico
E) Administrar ácido fólico y vitamina B12

PREGUNTA 12 1.08.1.002

12. Un paciente de 71 años presenta un cuadro de dos meses de adinamia, astenia y disnea de medianos esfuerzos, progresiva. Al examen físico se observa importante palidez de piel y mucosas, por lo que se piden exámenes entre los que destacan hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,8 g/dl, VCM: 65 fl, plaquetas: 400.000 por mm3, blancos: 5.600 por mm3, frotis: microcitosis, hipocromía, poiquilocitosis y anisocitosis, transferrina: 460 ug/dl y ferremia: 24 ug/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Solicitar biopsia de médula ósea
B) Realizar estudio endoscópico del tubo digestivo
C) Solicitar ferritina plasmática
D) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones
E) Transfundir glóbulos rojos

PREGUNTA 13 1.08.1.002

13. Un hombre de 57 años es diagnosticado de anemia ferropénica, mediante un hemograma y un perfil de fierro. La conducta más adecuada es:

A) Observar evolución
B) Solicitar colonoscopía y endoscopía digestiva alta e indicar sulfato ferroso, controlando nuevo perfil de hierro en 6 meses
C) Indicar sulfato ferroso hasta normalizar el hematocrito y la ferremia
D) Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional
E) Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional

PREGUNTA 14 1.08.1.002

14. Una mujer de 70 años es diagnosticada de anemia ferropénica, mediante un hemograma y un perfil de fierro. La conducta más adecuada es:

A) Observar evolución
B) Solicitar colonoscopía e indicar sulfato ferroso oral
C) Indicar aporte oral de hierro, con hierro maltosado y solicitar recuento de reticulocitos mensual
D) Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional
E) Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional

PREGUNTA 15 1.08.1.001

15. El tratamiento de la anemia por enfermedades crónicas suele ser:

A) Eritropoyetina subcutánea
B) Transfusiones periódicas
C) Hierro y Folatos por vía oral
D) Corticoides
E) El tratamiento de la enfermedad de base

PREGUNTA 16 1.08.1.001

16. Un paciente con anemia normocítica se realiza un perfil de fierro que muestra ferremia baja, transferrina baja y ferritina elevada. El diagnóstico más probable es:

A) Anemia hemolítica
B) Anemia por déficit de folatos
C) Anemia ferropénica
D) Anemia por enfermedades crónicas
E) Talasemia

PREGUNTA 17 1.08.1.008

17. El mejor tratamiento en la aplasia medular idiopática es:

A) Transplante de médula ósea
B) Quimioterapia combinada
C) Radioterapiayoncologia/ 1/8
D) Cloramfenicol
E) No tiene tratamiento

PREGUNTA 18 1.08.1.008

18. La causa más frecuente de aplasia medular es:

A) Idiopática
B) Secundaria a fármacos
C) Secundaria a infecciones virales
D) Congénita
E) Invasión tumoral

BLOQUE 2 ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

PREGUNTA 19 1.08.1.003

19. El tratamiento más eficaz del púrpura trombocitopénico trombótico es:

A) Corticoides orales
B) Corticoides + inmunosupresores endovenosos
C) Soporte transfusional
D) Soporte dialítico + plasmaféresis
E) Reposición de agua y electrolitos por vía endovenosa

PREGUNTA 20 1.08.1.003

20. La anemia hemolítica presenta todo lo siguiente, EXCEPTO:

A) Bilirrubina elevada, de predominio indirecto
B) LDH muy aumentada
C) Presencia de esquistocitos
D) Elevación de la haptoglobina
E) Elevación de los reticulocitos

PREGUNTA 21 1.08.1.004

21. Un paciente de 73 años presenta astenia y disnea de esfuerzos importante, asociada a gran palidez de piel y mucosas. Refiere, también, parestesias en las 4 extremidades. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina: 6 mg/dl, VCM: 126 fl, glóbulos blancos: 3.100 por mm3, plaquetas: 105.000 por mm3 y 2 eritroblastos / 100 leucocitos. Se solicitan, además, LDH: 1.800 UI/L y bilirrubina: 5 mg/dl, de predominio indirecto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Mielodisplasia
B) Aplasia medular
C) Anemia por déficit de vitamina B12
D) Síndrome leucoeritroblástico
E) Anemia hemolítica autoinmune

PREGUNTA 22 1.08.1.004

22. Una de estas causas produce anemia megaloblástica. Señálela:

A) Pancreatectomía total.
B) Anemia perniciosa.
C) Gastrinoma.
D) Enfermedad de Cröhn.
E) Déficit de vitamina B1.

PREGUNTA 23 1.08.1.004

23. Una paciente de 29 años, sin antecedentes, consulta por disnea progresiva asociada a fatigabilidad. Al examen físico destaca mucosas pálidas, cardiopulmonar normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 8.3mg/dL, hematocrito 26%, VCM 110, reticulocitos 0.3%, leucocitos 8.500/mm3 y plaquetas 200.000/mm3. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Anemia falciforme
B) Anemia perniciosa
C) Anemia ferropénica
D) Anemia por enfermedades crónicas
E) Anemia por déficit de vitamina B6

PREGUNTA 24 1.08.1.004

24. Adulto mayor con astenia, anemia, trombocitopenia, leucopenia, LDH elevada y VCM 123. ¿Diagnóstico más probable?

A) Leucemia aguda
B) Síndrome mielodisplásico
C) Anemia aplásica
D) Anemia megaloblástica
E) Linfoma no Hodgkin con compromiso medular

PREGUNTA 25 1.08.1.004

25. Un paciente de 71 años consulta por malestar general y disnea progresiva, que actualmente es de pequeños esfuerzos. Al examen Fsico se observa pálido, con examen cardiopulmonar que muestra ritmo regular en dos 8empos, sin soplos, con frecuencia cardíaca 120 la8dos por minuto; y examen pulmonar que constata murmullo pulmonar simétrico sin otros ruidos. Se solicita hemograma que se informa con hematocrito: 16%, hemoglobina: 5,2 g/dL, VCM: 118 fL, CHCM: 40 g/dL, re8culocitos: 0,8%, plaquetas: 60.000/mm³ y glóbulos blancos: 3.300/mm³. Además, se solicita GOT: 52 U/L, bilirrubina total: 3,5 mg/dL y bilirrubina directa: 0,2 mg/dL. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Anemia megaloblás2ca
B) Anemia aplásica
C) Anemia hemolí2ca
D) Mielodisplasia
E) Mielop2sis

PREGUNTA 26 1.08.1.004

26. Un paciente de 36 años, desde hace 4 años sigue dieta vegana estricta. Consulta por astenia, adinamia y palidez, a lo que se ha agregado disnea de grandes esfuerzos, que ha aumentado. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas, FC: 92x', PA: 100/70 mmHg, sin alteraciones del examen segmentario. Se solicita hemograma que muestra plaquetas: 200.000 por mm3, glóbulos blancos: 6.500 por mm3, hematocrito: 27%, hemoglobina: 9 g/dl, VCM: 115 fl, HCM: 35 pg y reticulocitos 0,5%, con LDH: 450 UI/L. El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

A) Nivel de vitamina B12
B) Mielograma
C) Biopsia de médula ósea
D) Perfil de fierro
E) Prueba de Coombs

PREGUNTA 27 1.08.1.004

27. Un paciente de 80 años presenta astenia, bradipsiquia, confusión y disnea de mínimos esfuerzos. Al examen físico se aprecia pálido, con FC: 115x, PA: 120/80 mmHg. Se realiza un hemograma, que muestra anemia con hemoglobina: 5,9 g/dl, HCM: 34 pg, VCM: 117 fl, blancos: 3.100 por mm3, plaquetas: 57.000 por mm3 y, además, destaca LDH: 890 UI/L. EL diagnóstico más probable es:

A) Anemia aplástica
B) Anemia hemolítica
C) Anemia megalobástica
D) Mielodisplasia
E) Mieloma múltiple

PREGUNTA 28 1.08.1.004

28. Un paciente de 60 años, gastrectomizado, presenta un cuadro de astenia, adinamia, asociada a disminución de la sensibilidad distal de las extremidades y debilidad. Además ha presentado algún grado de disminución de la capacidad cognitiva. Al examen físico se aprecia disminución de los reflejos osteotendíneos, palidez y disminución de la sensibilidad de las Extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con Hemoglobina de 6,3 g/dl, VCM: 110 fl, plaquetas: 200.000 por mm3, blancos: 3.200 por mm3. La indicación más adecuada es:

A) Ácido fólico
B) Vitamina B12
C) Fierro
D) Biopsia de médula ósea
E) Endoscopía digestiva alta

PREGUNTA 29 1.08.1.003

29. Un paciente de 29 años presenta ictericia, disnea y compromiso marcado del estado general. Su examen Fsico solo muestra ictericia de escleras y piel, sin alteraciones relevantes en el examen segmentario. Sus exámenes de laboratorio muestran hemograma con hematocrito: 12%, hemoglobina: 4,1 g/dL, plaquetas: 250.000/mm³, glóbulos blancos 7.800/mm³, VCM: 103 fL y CHCM: 32 pg; en el fro8s se observa presencia de microesferocitos. Las pruebas hepá8cas muestran GOT: 52 U/L, GPT: 56 U/L, bilirrubina total: 4,1 mg/dL, bilirrubina directa 0,5: mg/dL, GGT: 50 U/L, fosfatasas alcalinas: 211 U/L y LDH: 960 U/L. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Hepa22s A
B) Anemia por déficit de vitamina B12
C) Hemólisis
D) Anemia aplásica
E) Mielodisplasia

PREGUNTA 30 1.08.1.003

30. El tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune suele ser:

A) Eritropoyetina subcutánea
B) Transfusiones periódicas
C) Hierro y Folatos por vía oral
D) Corticoides
E) Trasplante de médula ósea

PREGUNTA 31 1.08.1.003

31. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS compatible con una anemia hemolítica autoinmune?

A) Prueba de coombs directa positiva
B) Haptoglobina bajayoncologia/ 1/6
C) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
D) Reticulocitos bajos
E) Macrocitosis

PREGUNTA 32 1.08.1.003

32. Un paciente de 46 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de disnea y palidez desde hace 2 semanas, asociado a coluria e ictericia. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas y se palpa esplenomegalia, sin otros hallazgos. El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:

A) Haptoglobina
B) LDH
C) Coombs
D) Hemograma con reticulocitos
E) Bilirrubina total e indirecta

PREGUNTA 33 1.08.1.003

33. Un paciente de 45 años, consulta por astenia, fiebre y orinas oscuras. Al examen físico se aprecia palidez, por lo que se solicita hemograma que demuestra hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,6 g/dl, VCM: 110 ft, blancos: 8.000 x mm3, con fórmula diferencial normal y plaquetas: 169.000 x mm3. El frotis sanguíneo visualiza abundantes reticulocitos y esquistocitos. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar perfil de hierro
B) Solicitar niveles de vitamina B12 y folatos
C) Solicitar biopsia de médula ósea
D) Solicitars de coagulación
E) Solicitarde Coombs directo

PREGUNTA 34 1.08.1.003

34. Paciente lúpica consulta por dolor abdominal, fiebre y orinas oscuras de 24 horas de evolución. Al examen se aprecia ictericia leve. En su analítica destaca hematocrito: 27%, plaquetas: 400.000, blancos: 11.400, bilirrubina de 4 mg/dl, de predominio indirecto, transaminasas normales, LDH:1070. La(s)(s) diagnóstica(s) para confirmar el diagnóstico es(son):

A) Biopsia de médula ósea
B) Frotis de médula ósea
C) Orina completa y ecografía abdominal
D) C3, C4 y anticuerpos anti-DNA doble hebra
E) Frotis sanguíneo yde coombs

PREGUNTA 35 1.08.1.003

35. Paciente de 45 años, consulta porque le indicaron que padecía de anemia. El hemograma constata recuento de blancos y plaquetas normales, Hcto: 33%, Hb: 11 mg/dl, VCM: 70. En el frotis se aprecia isocitosis y normalidad del índice de dispersión eritrocítica. Se solicita perfil de hierro que resulta normal. El diagnóstico más probable es:

A) Talasemia
B) Anemia ferropénica
C) Anemia de enfermedades crónicas
D) Anemia hemolítica crónica
E) Hemocromatosis

PREGUNTA 36 1.08.1.003

36. Una mujer de 36 años acude a la consulta como parte del control de su embarazo, de 20 semanas. El examen físico muestra los cambios normales del embarazo. Se toma hemograma, que demuestra Hematocrito: 33%, Hb: 11,2 g/dl, VCM:85, blancos y plaquetas normales. El diagnóstico más probable es:

A) Hemograma normal
B) Anemia ferropénica
C) Talasemiayoncologia/ 5/8
D) Anemia por enfermedades crónicas
E) Déficit de folatos

BLOQUE 3 HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

PREGUNTA 37 1.08.1.013

37. [ATENCIÓN PRIMARIA: Púrpuras vasculares · 1.08.1.013] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Púrpuras vasculares. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 1.08.2.009

38. [URGENCIA: Trombopenia severa · 1.08.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Trombopenia severa. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 39 1.08.1.005

39. Un niño de 4 años ha presentado 2 hemartrosis de rodilla y varios episodios de hematomas profundos. Con alta probabilidad presentará:

A) Alteración del recuento de plaquetas
B) Alteración de lass de agregación plaquetaria
C) Alteración de los niveles plamáticos de fibrinógeno
D) Alteración del TTPA
E) Alteración del TP

PREGUNTA 40 1.08.1.005

40. Un niño de 6 años ha presentado varios hematomas musculares espontáneos y algunas hemartrosis a lo largo de su vida. La madre refiere que con frecuencia presenta equimosis ante traumas menores. Usted esperaría encontrar:yoncologia/ 2/6

A) Disminución del recuento de plaquetas
B) Alargamiento del tiempo de sangría
C) Alargamiento del TTPA
D) Disminución del fibrinógeno
E) Alargamiento del tiempo de protrombina

PREGUNTA 41 1.08.1.012

41. Niño de 6 años previamente sano, sin medicamentos, consulta por púrpura petequial generalizada de inicio súbito posterior a infección viral. Plaquetas: 10.000/mm³. Resto del hemograma normal. Sin adenopatías ni visceromegalias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Púrpura trombocitopénica inmune (PTI)
B) Púrpura trombótica trombocitopénica
C) Síndrome hemolítico urémico
D) Coagulación intravascular diseminada
E) Leucemia aguda linfoide

PREGUNTA 42 1.08.1.012

42. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más orientador a una alteración de la hemostasia primaria?

A) Alargamiento del TTPA
B) Equímosis
C) Antecedentes familiares de hemorragias
D) Petequias
E) Hemartrosis

PREGUNTA 43 1.08.1.012

43. ¿Cuál es la segunda línea de tratamiento en un paciente de 55 años, sin antecedentes de interés, diagnosticado de púrpura trombocitopénica idiopática crónica, que no responde a esteroides tras 3 meses de terapia?:

A) Azatioprina.
B) Danazol.
C) Inmunoglobulinas i.v. a altas dosis.
D) Vincristina.
E) Esplenectomía.

PREGUNTA 44 1.08.1.006

44. Paciente con epistaxis, equimosis, gingivorragias frecuentes, antecedente familiar de epistaxis y menorragias, TTPA levemente prolongado. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trombocitopenia inmune primaria (PTI)
B) Hemofilia A
C) Déficit de factor XI
D) Enfermedad de Von Willebrand
E) Coagulación intravascular diseminada (CID)

PREGUNTA 45 1.08.1.006

45. ¿Cuál de los siguientes cuadros es más sugerente de una hemofilia?

A) Paciente de sexo masculino y 16 años, que ha sufrido varias hemartrosis de rodillas y otras articulaciones, de manera espontánea
B) Paciente de sexo masculino y 14 años, que presenta epistaxis frecuentes, asociado a aparición de petequias y equimosis con pequeños golpes.
C) Paciente de sexo femenino de 13 años, que presenta hematuria y artralgias, asociado a un púrpura de extremidades inferiores y hematoquezia.yoncologia/ 5/7
D) Paciente de sexo femenino, de 18 años, que desde su infancia ha prensentado tendencia a presentar equimosis, sangra más de lo normal en procedimientos dentales y tiene reglas muy abundantes.
E) Paciente de sexo masculino, de 5 años, que presenta un púrpura petequial generalizado, de 3 días de evolución, que empezó una semana después de una infección respiratoria alta. Respuestas: Prueba 5 HEMATOLOGÍA Preguntas Respuestas 1 A 2 D 3 C 4 C 5 E 6 E 7 E 8 C 9 A 10 D 11 B 12 B 13 C 14 D 15 C 16 D 17 D 18 A 19 D 20 Ayoncologia/ 6/7 Todos los Derechos Reservados para DrGuevarayoncologia/ 7/7

PREGUNTA 46 1.08.1.006

46. **Un niño de 6 años ha presentado varios hematomas musculares espontáneos y algunas hemartrosis a lo largo de su vida. La madre refiere que con frecuencia presenta equimosis ante traumas menores. El diagnóstico más probable es:**

A) Púrpura trombocitoénico inmune
B) Púrpura trombocitopénico trombótico
C) Hemofilia
D) Coagulación intravascular diseminada
E) Enfermedad de Von Willebrand

PREGUNTA 47 1.08.1.006

47. **Un paciente de 18 años presenta equimosis frecuente y tendencia a presentar petequias en las extremidades inferiores. Como antecedente, presentó hemorragia tardía, en relación a la extracción de un molar y hace algunos años sufrió un hematoma en el muslo izquierdo, en relación a un traumatismo, que requirió manejo hospitalizado. Se solicitan exámenes que muestran hemograma con 160.000 plaquetas por mm3, sin alteraciones de la serie roja ni blanca, TTPA de 45 segundos y TP de 100%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Glanzmann
B) Enfermedad de von Willebrand
C) Déficit de factor VII
D) Hemofilia
E) Púrpura trombopénica inmune

PREGUNTA 48 1.08.1.006

48. **Un joven de 18 años presenta sangrado prolongado, luego de la extracción de un molar. Además refiere equimosis ante pequeños traumatismos y epistaxis frecuente. Hace unos años estuvo hospitalizado por un hematoma profundo del muslo derecho. Su hemograma es normal y su TTPA está levemente alargado, con protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:**

A) Enfermedad de Von Willebrand
B) Púrpura trombopénico inmune
C) Enfermedad de Glanzmann
D) Hemofilia
E) Factor V de Leiden

PREGUNTA 49 1.08.2.003

49. **[URGENCIA: Coagulopatía congénita sangrante · 1.08.2.003] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Coagulopatía congénita sangrante. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 50 1.08.1.005

50. **Una mujer de 68 años con antecedentes de AC-VA isquémico derecho, cardiopatía isquémica (angina crónica estable), hipertensión arterial bien controlada y diabetes mellitus tipo 2, consulta por un episodio de AIT (ataque isquémico transitorio). En la tomografía axial computarizada no se observan cambios en la imagen cerebral previa y en el electrocardiograma se confirma la existencia de una fibrilación auricular, con respuesta ventricular normal, cuya reversión a ritmo sinusal, tanto eléctrica como farmacológica, había fracasado previamente. En la ecografía se observa la existencia de una aurícula izquierda aumentada de tamaño. Los días antes del último episodio seguía tratamiento con aspirina (150 mg diarios). ¿Cuál sería su consejo terapéutico?:**

A) Iniciaría tratamiento con acenocumarol como terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular.
B) Sustituiría la aspirina por clopidogrel.
C) Añadiría clopidogrel a la aspirina
D) Duplicaría la dosis de aspirina.
E) Antes de retirar la aspirina intentaría una nueva reversión farmacológica

PREGUNTA 51 1.08.1.005

51. **Las causas más frecuentes de daño hepático crónico en Chile son:**

A) Alcohol y hepatitis C
B) Alcohol y hepatitis B
C) Alcohol y tumoral 15gastroenterologia/ 4/8
D) Alcohol y NASH
E) Alcohol y autoinmune

PREGUNTA 52 1.08.2.002

52. **Un paciente de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial y una válvula cardíaca aórtica mecánica, anticoagulado con antagonistas de la vitamina K, ingresa al servicio de urgencias por un episodio de hemorragia digestiva alta, con signos de inestabilidad hemodinámica. Además de la administración de fluidos y la solicitud de una endoscopía digestiva alta con urgencia, ¿cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?**

A) Administrar vitamina K por vía endovenosa
B) Transfundir sangre completa
C) Administrar ácido tranexámico endovenoso
D) Administrar plasma fresco congelado endovenoso
E) Administrar factor VII recombinante endovenoso

PREGUNTA 53 1.08.2.001

53. **Una mujer puérpera, preseenta hemorragia postparto importante. En sus exámenes destacan hemograma con hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,3 g/dl, glóbulos blancos: 8.000 por mm3, plaquetas: 80.000 y además tiene TTPA y TP alargados y fibrinógeno 90 mg/dl (VN: 200 a 400) ¿Cuál es la mejor indicación transfusional?**

A) Crioprecipitado
B) Glóbulos rojos
C) Plaquetas
D) Sangre fresca
E) Plasma fresco congelado

PREGUNTA 54 1.08.2.001

54. **Un paciente con antecedente de un factor V de Leyden presenta súbitamente disnea y dolor torácico, con tope inspiratorio a derecha. No presenta compromisos hemdinámico ni desaturación importante. Se solicita un angioTAC que es compatible con un tromboembolismo pulmonar derecho. Se decide iniciar anticoagulación con heparina no fraccionada (heparina de alto peso molecular) por vía endovenosa. ¿Qué examen debe realizar para controlar un adecuado nivel de anticoagulación?**

A) Tiempo de protrombina (TP) e INR
B) Tiempo de trombina (TT)
C) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)
D) Tiempo de sangría
E) No requiere control con exámenes

BLOQUE 4 ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

PREGUNTA 55 1.08.1.009

55. **Paciente de 25 años, presenta desde hace 3 semanas compromiso del estado gene- ral, sensación febril cuantificada hasta 38°C, asociado a astenia y tendencia a presentar equimosis frente a pequeños traumatismos. Al examen físico se aprecia pálida, se palpa esplenomegalia y se observan abundantes petequias en abdomen y extremidades infe- riores asociadas a equimosis en extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probble?**

A) Leucemia aguda
B) Mononucleosis infecciosa
C) Linfoma
D) Síndrome hemolítico uremico
E) Coagulación intravascular diseminada

PREGUNTA 56 1.08.1.009

56. **Paciente de 50 años, consulta por astenia y fiebre ocasional, de 3 semanas de evolución. Al examen destaca esplenomegalia y palidez. El hemograma muestra Hcto: 29%, Hb: 9,2 g/dl blancos: 43.000, con 5% de linfocitos y 95% de neutrófilos, con 10% segmentados, 0% baciliformes, 0% mielocitos, 74% promielocitos con aumento de cantidad de citoplasma, núcleo bilobulados, plegado, con abundantes gránulos y 6% de blastos. El diagnóstico más probable es:**

A) Leucemia mieloide crónica
B) Leucemia mieloide aguda
C) Mononucleosis infecciosa
D) Fiebre tifoídea
E) Mielodiplasia

PREGUNTA 57 1.08.1.009

57. **Un enfermo de 30 años, que consulta por cansancio, presenta un hemograma con una cifra de leucocitos de 4.800/microL y un porcentaje de blastos del 75%. Su diagnóstico es:**

A) Anemia refractaria con exceso de blastos.
B) Leucemia linfática crónica.
C) Leucemia mieloide aguda.
D) Leucemia mieloide crónica en fase crónica.
E) Leucemia mielomonocítica crónica.

PREGUNTA 58 1.08.1.009

58. **Un paciente de 86 años acude a control por astenia y malestar general de 2 meses de evolución, asociado a bradipsiquia en el último tiempo. Al examen físico, se aprecia palidez de piel y mucosas y se constatan signos vitales con FC: 110x', PA: 126/76 mmHg, sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma, con hematocrito 16%, hemoglobina: 5,3 g/dl, VCM: 126 ft, glóbulos blancos: 3.300 por mm3, plaquetas: 108.000 por mm3, bilirrubina: 3,6 mg/dl, con fracción directa de 0,6 mg/dl, LDH: 1.012 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Mielodisplasia
B) Mieloma múltiple
C) Anemia hemolítica
D) Anemia megaloblástica
E) Leucemia mieloide aguda

PREGUNTA 59 1.08.1.009

59. Paciente femenina, de 17 años presenta astenia, decaimiento, dolores óseos y pérdida de peso, de 2 meses evolución. Al examen físico se constatan múltiples adenopatías cervicales y axilares, con bazo palpable 3 cm debajo del reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Linfoma de Hodgkin
B) Leucemia mieloide aguda
C) Leucemia linfática aguda
D) Síndrome mononucleósico
E) Leucemia linfática crónica

PREGUNTA 60 1.08.1.010

60. Un paciente de 81 años, en espera de una cirugía de cataratas, se realiza un hemograma, como parte de los exámenes preoperatorios, que muestra 140.000 blancos, con predominio de linfocitos, de aspecto redondo, con citoplasma escaso, cromatina heterogénea y sombras de Gumprecht, además tiene hemoglobina de 13,1 g/dl y 180.000 plaquetas por mm3. Al examen físico se palpa una adenopatía cervical de 3 cm, indolora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Leucemia aguda
B) Mielodisplasia
C) Leucemia mieloide crónica
D) Linfoma
E) Leucemia linfática crónica

PREGUNTA 61 1.08.1.010

61. ¿Cuál de las siguientes patologías es un síndrome mielorpoliferativo?

A) Linfoma
B) Leucemia de células peludas
C) Leucemia mieloide crónica
D) Mielodisplasia
E) Mieloptisis

PREGUNTA 62 1.08.1.010

62. La asociación de leucocitosis elevada de predominio neutrofílico, desviación izquierda marcada y trombocitosis es característica de:

A) Sepsis por bacterias Gram negativas
B) Reacción leucemoide
C) Leucemia aguda promielocítica
D) Leucemia aguda mielocítica
E) Leucemia crónica mieloide

PREGUNTA 63 1.08.1.011

63. Una paciente de 20 años consulta por aumento de volumen en el cuello de 2 meses de evolución, asociado a leve malestar general, fiebre ocasional y sudoración nocturna. Al examen físico, se palpan adenopatías submandibulares y cervicales bilaterales de consistencia aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tuberculosis ganglionar
B) Linfoma
C) Infección por VIH
D) Sarcoidosis
E) Mononucleosis infecciosa

PREGUNTA 64 1.08.1.011

64. Respecto a los linfomas de bajo grado, es FALSO que:

A) La tasa de recaídas después del tratamiento con quimioterapia, suele ser muy bajayoncologia/ 3/9
B) Al momento del diagnóstico suelen estar diseminados
C) Suelen presentar sobrevidas sobre los 10 años
D) En los adultos mayores, suelen observarse
E) Se diagnostican mediante biopsias ganglionares

PREGUNTA 65 1.08.1.011

65. Los linfomas suelen derivarse de las siguientes alteraciones genéticas:

A) Mutaciones autosómicas dominantes
B) Mutaciones autosómicas recesivas
C) Mutaciones ligadas al sexo
D) Translocaciones cromósómicas
E) Aneuploidías

PREGUNTA 66 1.08.1.007

66. Pregunta 37 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente de 64 años consulta por dolores óseos. Se realiza un hemograma que muestra hematocrito: 24%, con hemoglobina: 8g/dl, VC;: 85 fl, plaquetas: 180.000 por mm3 y blancos: 5.800 por mm3, con VHS: 90 mm/h. En los otros exámenes, destaca hipogamaglobulinemia y en el análisis de proteínas séricas se objetiva elevación monoclonal de proteínas, en la zona Kappa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Macroglobulinemia de Waldeström
B) Gamapatía monoclonal incierta
C) Mieloma múltiple
D) Amiloidosis
E) Enfermedad por cadenas pesadas

PREGUNTA 67 1.08.1.007

67. Paciente de 65 años, con dolores óseos, presenta en su analítica creatinina de 2,1, anemia con Hb:9,7 e hipercalcemia de 11,1. El diagnóstico de sospecha es:

A) Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo asociado
B) Anemia de enfermedades crónicas
C) Mieloma múltiple
D) Déficit de proteína C
E) Cáncer de próstatayoncologia/ 2/7

PREGUNTA 68 1.08.1.007

68. Un paciente de 67 años se realiza un perfil bioquímico que muestra elevación de las proteínas plasmáticas, con albúmina de 3,4 g/dl. Los exámenes generales son normales, al igual que el examen físico. Se solicita una electroforesis de proteínas en plasma, que constata un peak monoclonal de inmunoglobulina G, por lo que se realiza una realiza una biopsia de médula ósea que demuestra elevación del número de plasmocitos, compatible con un MGUS (Gamapatía monoclonal de significado incierto). La conducta más adecuada es:

A) Obsevar evolución
B) Indicar quimioterapia
C) Iniciar ácido acetil salicílico
D) Iniciar hidroxiurea
E) Realizar trasnplante de médula ósea 13 ¿Cuáles de estos signos biológicos suelen observarse tanto en las anemias hemolíticas, como en las pérdidas de sangre por hemorragia?:

PREGUNTA 69 1.08.1.007

69. Un paciente de 65 años, con cuadro de compromiso del estado general de tres meses de evolución asociado a nicturia y en las últimas semanas dolor lumbar. Al examen físico destaca paciente enflaquecido, piel seca y mucosas pálidas. Se solicitan exámenes de orina que muestra proteinuria ++, urocultivo negativo, 2-3 glóbulos rojos por campo, creatinina 1,8mg/dL y antígeno prostático de 5,5 (VN <4). Además se realiza ecografía renal que muestra dos quistes renales en lado derecho, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Mieloma múltiple
B) Cáncer prostático metastásico
C) Cáncer renal metastásico
D) Espondilodiscitis crónica
E) Espondilolistesis

PREGUNTA 70 1.08.1.018

70. Un paciente de 54 años, presenta un cuadro de varias semanas de evolución de aste- nia, adinamia y disnea que aparecen a los grandes esfuerzos Al examen físico se apre- cia palidez de piel y mucosas, se palpa el hígado 6 cm bajo el reborde costal derecho y el bazo se palpa 10 cm bajo el reborde costal izquierdo. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito de 29% con hemoglobina de 9,6g/dL, blancos 4.200/mm3, plaque- tas 111.000/mm3 y al frotis se aprecia macrocitosis y abundantes dacriocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Mieloptisis
B) Mieloma multiple
C) Leucemia mieloide crónica
D) Mielodisplasia
E) Mielofibrosis primaria

PREGUNTA 71 1.08.1.018

71. Un paciente de 67 años, sin antecedentes de importancia se realiza exámenes de control, destacando un hemograma que demuestra hematocrito: 62%, hemoglobina: 20,6 g/dl, plaquetas: 500.000 por mm3, blancos: 7.800 por mm3, con fórmula diferencial normal. Al examen físico destaca esplenomegalia. El diagnóstico más probable es:

A) Hemograma normal
B) Anemia por enfermedades crónicas
C) Policitemia vera
D) Trombocitosis esencial
E) Poliglobulia por hipoxemia.

PREGUNTA 72 1.08.1.018

72. Un paciente de 50 años consulta por poliglobulia, encontrada en un hemograma. Luego de un estudio acabado se concluye que padece de policitemia vera de bajo riesgo. El tratamiento más adecuado es:

A) Eritropoyetina subcutánea y aspirina
B) Quimioterapia combinada y aspirina
C) Sangrías periódicas y aspirina
D) Anticoagulación oral a permanencia
E) Trasplante de médula óseayoncologia/ 2/8

BLOQUE 5 URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

PREGUNTA 73 1.08.2.006

73. Una paciente de 56 años tiene antecedentes de cáncer de mama, en tratamiento con quimioterapia cuyo último ciclo fue hace 9 días. Consulta porque ha presentado malestar general y fiebre hasta 38,5°C. Al examen físico, se confirma febril, con frecuencia cardíaca 95x', PA: 120/80, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Hemograma
B) Radiografía de tórax
C) Urocultivo
D) Ecografía abdominal
E) Mielograma

PREGUNTA 74 1.08.2.006

74. Un paciente de 5 años, sin antecedentes de importancia presenta cuadro de 3 días de evolución de exantema petequial, asociado a sangramiento gingival al cepillarse los dientes. La madre refiere que cursó con una infección respiratoria alta, autolimitada, hace 10 días. Al examen físico se aprecia paciente en buenas condiciones, afebril, con un exantema petequial generalizado. El examen más importante para confirmar la sospecha diagnóstica es:

A) Hemograma con recuento de plaquetas
B) Hemocultivos
C) Pruebas de agregación plaquetaria
D) Tiempo de sangría
E) Tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial activada

PREGUNTA 75 1.08.2.006

75. **Un paciente con leucemia se realiza quimioterapia, evolucionando con una marcada neutropenia. Al 5 día post-quimioterapia presenta fiebre hasta 39°C. Usted sabe que la mayoría de las infecciones bacterianas en los pacientes neutropénicos febriles es causada por Pseudomona aureginosa y que de manera empírica debe ser tratado con doble cobertura para esta bacteria. ¿Qué combinación de antibióticos es más adecuada?**

A) Ceftriaxona + gentamicina
B) Piperacilina + vancomicina
C) Ciprofloxacino + metronidazol
D) Levofloxacino + clindamicina
E) Ceftazidina + amicacina

PREGUNTA 76 1.08.2.004

76. **Un paciente de 64 años, con antecedente de haber sido tratado por un mieloma, con buena respuesta, consulta ahora por cuadro de astenia, con constipación y aumento del volumen urinario, a lo que luego se le agrega desorientación. Al examen físico se aprecia soporoso, pálido. En sus exámenes presenta hematocrito 27%, con Hb: 9 g/dl, VHS: 93 mm/h, proteínas plasmáticas: 7,8 g/dl, albúmina: 3,7 g/dl, sodio: 140 mEq/L, potasio: 4,8 mEq/L, calcio: 14,3 mg/dl. En este momento debe recibir:**

A) Calcitonina
B) Solución salina al 0,9%
C) Vitamina D
D) Bifosfonatos
E) Corticoides

PREGUNTA 77 1.08.2.004

77. **Paciente con cáncer de próstata y calcio de 14 mg/dL. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Bifosfonatos endovenosos (ácido zoledrónico)
B) Suero fisiológico endovenoso (hidratación agresiva)
C) Calcitonina intranasal
D) Prednisona oral 40 mg/día
E) Diálisis de urgencia

PREGUNTA 78 1.08.2.005

78. **Un paciente de 55 años, diagnos8cado con un linfoma no Hodgkin con múl8ples masas medias`nicas y abdominales de gran tamaño, de hasta 25 cm, inicia quimioterapia endovenosa. Al tercer día evoluciona con malestar general marcado, obnubilación y disnea. Al examen Fsico, se aprecia desorientado en el 8empo y el espacio, en malas condiciones generales y se solicitan exámenes de laboratorio, entre los que destacan ácido úrico: 13 mg/dL, sodio: 140 mEq/L, potasio: 5,9 mEq/L, fósforo: 6,5 mg/dl, crea8nina plasmá8ca: 2,1 mg/dl y hematocrito 22%. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Hipercalcemia maligna
B) Metástasis cerebrales
C) Síndrome de vena cava superior
D) Síndrome de compresión medular
E) Síndrome de lisis tumoral

PREGUNTA 79 1.08.2.005

79. **El tratamiento de primera línea de la leucemia linfática aguda suele ser:**

A) Quimioterapia de inducción y radioterapia posterior a los huesos esponjosos
B) Trasplante de médula ósea
C) Quimioterapia combinada de inducción y luego de mantención
D) Quimioterapia combinada de inducción sola
E) Exanguíneotransfusión y radioterapia

PREGUNTA 80 1.08.2.005

80. **El pronóstico de sobrevida de la leucemia linfática aguda de la infancia actualmente es aproximadamente:**

A) 85%
B) 60%
C) 30%
D) 10%
E) 2%

PREGUNTA 81 1.08.2.005

81. **Paciente con linfoma en quimioterapia. Post primer ciclo presenta hiperuricemia, hiperkalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Creatinina en ascenso. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Síndrome de lisis tumoral
B) Insuficiencia renal aguda prerenal
C) Nefrotoxicidad por cisplatino
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Hiperparatiroidismo secundario

PREGUNTA 82 1.08.2.005

82. **Paciente con leucocitosis, 80% blastos linfoides, hiperuricemia, hipocalcemia y fósforo límite alto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Quimioterapia de inducción inmediata
B) Rasburicasa e iniciar quimioterapia
C) Transfusión de glóbulos rojos y plaquetas
D) Hemodiálisis urgente
E) Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral)

PREGUNTA 83 1.08.2.007

83. [URGENCIA: Síndrome de compresión medular · 1.08.2.007] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Síndrome de compresión medular. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 84 1.08.1.019

84. Un paciente de 32 años, presenta una trombosis venosa profunda femoropoplítea. Como antecedente, su abuelo falleció a los 85 años, por un accidente vascular encefálico y su padre tuvo un infarto agudo al miocardio a los 60 años. En sus exámenes destacan plaquetas: 140.000 por mm3, TTPA prolongado y VDRL (+). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Déficit de antitrombina III
B) Déficit de factor VIII
C) Síndrome antifosfolípidos
D) Púrpura trombocitopénica trombótica
E) Enfermedad de Von Willebrand

PREGUNTA 85 1.08.1.019

85. ¿Cuál de las siguientes trombofilias congénitas es más severa?:

A) Factor V de Leiden
B) Déficit de antitrombina III
C) Déficit de proteína C
D) Déficit de proteína S
E) Hiperhomocisteinemia

PREGUNTA 86 1.08.1.019

86. Enferma de 36 años con antecedentes de esplenectomía por trombocitopenia a los 22 años y cuatro abortos, el último seguido de un cuadro de trombosis venosa profunda. Desde hace unas 8 semanas presenta un cuadro de artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre. ¿Cuál de las siguientess de laboratorio cree de mayor utilidad para llegar al diagnóstico?:

A) Factor reumatoide y anticuerpos antinucleares (ANA).
B) Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticardiolipina.
C) Factor reumatoide y anticuerpo enfermedad de Lyme.
D) Anticuerpo anti-ADN nativo y anti-Ro (SSA).
E) Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCAs) y antihistonas.

PREGUNTA 87 1.08.1.019

87. Un paciente de 18 años consulta por dolor y aumento de volumen en la pantorrilla izquierda, en relación a un pequeño traumatismo. Se solicita un estudio Doppler de las extremidades inferiores, que muestra alteraciones del drenaje venoso profundo de la zona. En sus exámenes, se constata hematocrito: 38%, hemoglobina: 12,8 g/dl, plaquetas: 145.000 por mm3, blancos: 8.000 por mm3, TTPA 54 segundos, protrombina: 85%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Déficit de antitrombina III
B) Hemofilia A
C) Trombofilia por anticoagulante lúpico
D) Hemofilia B
E) Enfermedad de Von Willebrand

PREGUNTA 88 1.08.1.014

88. [ATENCIÓN PRIMARIA: Reacción leucemoide · 1.08.1.014] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Reacción leucemoide. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 89 1.08.3.005

89. ¿Qué grupo(s) de sangre puede recibir un paciente de grupo AB, que requiere de una transfusión, sin mayor riesgo de una reacción hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico?

A) Sólo AB
B) AB, A y B
C) O, A, B y AB
D) O y AB
E) A y B

PREGUNTA 90 1.08.3.005

90. Un paciente de grupo sanguíneo A recibe una transfusión de glóbulos rojos AB. ¿Cuál es la probabilidad de que se presente una reacción hemolítica tranfusional?

A) Mayor al 95%yoncologia/ 3/8
B) 65%-95%
C) 35%-65%
D) 5%-35%
E) Menor al 5%

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: A

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

Tanto por tener AR, como por la ferremia baja, con transferrina baja, orienta mu- cho a una anemia por enfermedades crónicas.

PREGUNTA 2 Respuesta: A

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

La respuesta correcta es solicitar una biopsia de médula ósea. El paciente presenta trombocitopenia (plaquetas disminuidas) y macrocitosis leve (VCM elevado), con un recuento de glóbulos rojos que no se especifica pero implícitamente se asume dentro de la normalidad dado que no se menciona anemia. La elevación aislada del VCM sin anemia clara, junto con la trombocitopenia, puede ser indicativa de una patología medular subyacente que afecta la producción de todas las líneas celulares. La VHS elevada (32 mm/h) es un marcador inespecífico de inflamación, pero en el contexto de las alteraciones hematológicas, podría ser un signo de alarma. Ante la sospecha de una disfunción medular que no puede ser explicada por deficiencias nutricionales comunes o por hemólisis, la biopsia de médula ósea es el estudio de elección para evaluar la celularidad, la morfología de las células hematopoyéticas y descartar condiciones como síndromes mielodisplásicos, aplasia medular o infiltración neoplásica. Análisis de distractores: b) Iniciar vitamina B12 y folatos: Si bien la deficiencia de vitamina B12 o folatos causa macrocitosis, generalmente se asocia con anemia megaloblástica y otras citopenias. Sin embargo, la ausencia de anemia o de otras manifestaciones clínicas que sugieran estas deficiencias, sumado a la trombocitopenia, hace que iniciar este tratamiento empíricamente sin un diagnóstico sea precipitado. La biopsia de médula ósea permitirá confirmar o descartar estas deficiencias si se observan megaloblastos u otras alteraciones características. c) Iniciar sulfato ferroso: El sulfato ferroso se utiliza para tratar la anemia por deficiencia de hierro. La macrocitosis (VCM elevado) es opuesta a lo que se observa en la deficiencia de hierro, donde el VCM suele estar disminuido. Por lo tanto, esta opción es incorrecta. d) Solicitar niveles plasmáticos de homocisteína: Los niveles elevados de homocisteína pueden estar asociados a deficiencia de vitamina B12 o folatos, pero solicitar este examen sin una sospecha clínica fuerte o como primera medida ante una trombocitopenia y macrocitosis no explicada, es menos preciso que evaluar directamente la médula ósea. e) Solicitar prueba de Coombs directo y haptoglobina: La prueba de Coombs directo se utiliza para detectar anemia hemolítica autoinmune, y la haptoglobina ayuda a evaluar la hemólisis. Dado que no hay evidencia de hemólisis en la descripción del caso (no se menciona anemia, ictericia, o hallazgos de laboratorio que sugieran hemólisis), estas pruebas no serían la prioridad ni la conducta más adecuada inicialmente.

PREGUNTA 3 Respuesta: C

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

La anemia normocítica normocrómica indica que los glóbulos rojos tienen un tamaño y contenido de hemoglobina normales, lo que limita las opciones iniciales. El índice reticulocitario bajo sugiere que la médula ósea no está respondiendo adecuadamente a la anemia, es decir, no está produciendo suficientes glóbulos rojos. La ferritina baja (depósitos de hierro disminuidos), la ferremia baja (hierro en sangre bajo) y la transferrina elevada (proteína transportadora de hierro aumentada) son hallazgos clásicos de anemia ferropénica. El cuerpo intenta compensar la falta de hierro aumentando la producción de transferrina para capturar la mayor cantidad de hierro posible. En resumen, la combinación de una anemia normocítica normocrómica con bajo índice reticulocitario y un perfil de hierro compatible con deficiencia (ferritina baja, ferremia baja y transferrina alta) apunta fuertemente a una anemia ferropénica en una fase inicial donde aún no se ha desarrollado la microcitosis e hipocromía típicas de la anemia ferropénica crónica. La anemia ferropénica es la causa más común de anemia en la práctica clínica. Análisis de distractores: * **a) Mielodisplasia:** La mielodisplasia es un síndrome donde la médula ósea no produce células sanguíneas normales. Aunque puede causar anemia, típicamente se asocia con citopenias en otras líneas celulares (leucopenia, trombocitopenia) y con reticulocitos normales o altos, además de frotis con displasia. El perfil de hierro no suele ser el de una ferropenia establecida. * **b) Anemia de enfermedades crónicas:** Esta anemia también suele ser normocítica normocrómica (aunque a veces puede ser microcítica), pero el perfil de hierro es distinto. La ferritina suele estar normal o alta (porque el hierro está atrapado en los macrófagos), la ferremia es baja y la transferrina es normal o baja. El índice reticulocitario suele ser bajo. * **d) Hemocromatosis:** Es una condición de sobrecarga de hierro. La ferritina y la ferremia estarían elevadas, y la transferrina estaría baja o normal. * **e) Anemia hemolítica:** Generalmente cursa con un aumento de reticulocitos (respuesta compensatoria de la médula ósea) y otros signos de hemólisis, como aumento de LDH y bilirrubina indirecta. El perfil de hierro no se ajusta a una ferropenia.

PREGUNTA 4 **Respuesta: A**

Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

1.08.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome leucoeritroblástico" (1.08.1.015), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 5 **Respuesta: A**

Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

1.08.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome paraneoplásico" (1.08.1.016), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 6 **Respuesta: A**

Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

1.08.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndromes mielodisplásicos" (1.08.1.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 7 **Respuesta: D**

Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

1.08.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome de vena cava superior: Caracterizado por obstrucción del flujo a través de la VCS con edema facial, distensión yugular, tos y disnea. En cáncer de células pequeñas, el tratamiento clásico es la radioterapia urgente (aunque actualmente se prefiere quimioterapia + stent).

PREGUNTA 8 **Respuesta: B**

Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina

1.08.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Anemia ferropénica con indicación de hierro endovenoso: El diagnóstico es una anemia moderada ferropénica, confirmada por la ferritina plasmática baja (reflejo de los depósitos de hierro) y la saturación de transferrina menor al 20%. La paciente requiere suplementación de hierro, y en este caso, la vía debe ser endovenosa debido a la cirugía de bypass gástrico, un factor de riesgo para la malabsorción de hierro, ya que se absorbe principalmente en el duodeno, por lo que las cirugías en esta área pueden afectar su absorción, similar a lo que ocurre en la enfermedad celíaca, donde el duodeno suele ser el segmento intestinal más afectado.

PREGUNTA 9 **Respuesta: A**

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina

La deficiencia de hierro (ferropénica) es la causa más común de anemia a nivel mundial. Se caracteriza por una disminución en las reservas de hierro del organismo. La ferritina es la principal proteína de almacenamiento de hierro en el cuerpo; por lo tanto, en un estado de deficiencia de hierro, los niveles de ferritina sérica se encuentran bajos, reflejando la escasez de hierro almacenado. Por otro lado, la transferrina es la principal proteína transportadora de hierro en la sangre. Ante una disminución del hierro disponible, el cuerpo intenta compensar aumentando la producción de transferrina. Esto se debe a que la hepcidina, la hormona reguladora del hierro, disminuye en la ferropénica, lo que a su vez promueve la síntesis de transferrina en el hígado. Un aumento en la transferrina circulante permite captar de manera más eficiente el escaso hierro disponible en la dieta y transportarlo a la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. La combinación de ferritina disminuida y transferrina elevada (o su índice, la capacidad total de fijación de hierro o TIBC, que estará aumentada) es el marcador bioquímico clásico de la ferropénica. Esta alteración refleja simultáneamente la depletedz de las reservas de hierro (baja ferritina) y el intento del organismo por movilizar y captar el hierro circulante (alta transferrina). Estos hallazgos son fundamentales para el diagnóstico diferencial de la anemia, distinguiéndola de otras causas como la anemia de enfermedad crónica o las anemias megaloblásticas. Análisis de distractores: b) Ferritina aumentada y transferrina disminuida: Esto sería característico de una sobrecarga de hierro o de un estado inflamatorio donde la transferrina se comporta como reactante de fase aguda negativo. c) Ferritina y transferrina aumentadas: La ferritina elevada suele indicar un aumento de las reservas de hierro o un estado inflamatorio/infeccioso. Si bien la transferrina podría estar aumentada en ciertos contextos, la combinación no es típica de ferropénica. d) Ferritina y transferrina disminuidas: La ferritina disminuida es típica de ferropénica, pero una transferrina disminuida no lo es; de hecho, el cuerpo intenta aumentarla. Podría verse una disminución conjunta en estados de malnutrición severa o enfermedad hepática crónica. e) Ferritina y transferrina dentro de rangos normales: Si bien es posible que en etapas muy tempranas de deficiencia de hierro estos valores estén normales, en la ferropénica establecida, estos parámetros están alterados.

PREGUNTA 10 **Respuesta: B**

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina

La anemia ferropénica se caracteriza por una deficiencia de hierro en el organismo. La ferritina es la principal proteína de almacenamiento de hierro, por lo tanto, en un estado de deficiencia de hierro, sus niveles disminuyen. La transferrina, por otro lado, es la proteína encargada de transportar el hierro en el plasma. Cuando hay deficiencia de hierro, el cuerpo intenta compensar aumentando la producción de transferrina para maximizar la captación de cualquier hierro disponible, resultando en una elevación de los niveles de transferrina. La saturación de transferrina (porcentaje de transferrina unida a hierro) también disminuye en la anemia ferropénica, aunque la pregunta se centra en los niveles absolutos de ferritina y transferrina. El aumento de la transferrina es una respuesta compensatoria para captar todo el hierro disponible, mientras que la ferritina refleja directamente el estado de los depósitos de hierro en el cuerpo. Análisis de distractores: a) **Elevación de la ferritina y de la transferrina:** La ferritina se eleva en estados de inflamación o sobrecarga de hierro, no en deficiencia. c) **Elevación de la ferritina y disminución de la transferrina:** Incorrecta por la misma razón que la opción a; la ferritina baja y la transferrina sube en anemia ferropénica. d) **Disminución de la ferritina y de la transaferrina:** La ferritina disminuye correctamente, pero la transferrina aumenta como respuesta compensatoria. e) **Disminución de la ferritina, aumento de la ferremia y disminución de la saturación de la tranferrina:** La ferremia (hierro sérico) puede estar normal o baja en la anemia ferropénica, pero no necesariamente aumentada. Si bien la saturación de transferrina disminuye, lo clave es la relación entre ferritina y transferrina, que esta opción confunde.

PREGUNTA 11 **Respuesta: A**

1.08.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina

Suplementación de Hierro en Anemia Posparto: En una paciente con anemia moderada secundaria a hemorragia posparto, se recomienda la suplementación con hierro para compensar las pérdidas, incluso si no se ha confirmado la deficiencia de hierro. La vía de administración puede ser oral o intravenosa. La vía oral suele ser suficiente para una recuperación completa, por lo que suele ser la de elección, mientras que la vía intravenosa ofrece una recuperación más rápida del hematocrito y es una alternativa del todo aceptable.

PREGUNTA 12 **Respuesta: E**

1.08.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina

Es una pregunta muy discutible, ya que tiene una clara anemia ferropénica, grave y se debe estudiar la presencia de cáncer digestivo, ya que es un adulto mayor. Sin embargo, probablemente sí se lo deba transfundir, ya que tiene una anemia muy sintomática. Por regla general, pero no absoluta, no se transfunden si tiene Hb mayor o igual a 10 g/dl y se suelen transfundir casi todos, si está menor a 7 g/dl. Entre 7 y 10, se ve caso a caso (aunque siempre se ve caso a caso). Dada la forma en que está redactada, recomiendo marcar la transfusión.

PREGUNTA 13 **Respuesta: B**

Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

1.08.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En un hombre de 57 años con diagnóstico de anemia ferropénica confirmada por hemograma y perfil de hierro, la conducta más adecuada es investigar la causa subyacente de la pérdida de hierro. A esta edad, la anemia ferropénica en hombres se asocia frecuentemente a pérdidas crónicas de sangre gastrointestinales, que pueden ser debidas a patologías como úlceras pépticas, enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos o neoplasias. Por lo tanto, es fundamental realizar estudios endoscópicos como la endoscopía digestiva alta y la colonoscopía para identificar y tratar la fuente de sangrado. Paralelamente, se debe iniciar tratamiento con suplementos de hierro, como el sulfato ferroso, y monitorizar la respuesta hematológica y los niveles de hierro. El objetivo del tratamiento con sulfato ferroso es reponer las reservas de hierro y normalizar los parámetros hematológicos. Sin embargo, la duración del tratamiento no debe basarse únicamente en la normalización del hematocrito y la ferremia, ya que es crucial asegurar la corrección de la causa subyacente para prevenir recurrencias. El control periódico del perfil de hierro es necesario para evaluar la efectividad del tratamiento y la adecuada reposición de las reservas. Análisis de distractores: a) Observar la evolución: La anemia ferropénica, especialmente en un hombre de 57 años, requiere investigación activa de la causa subyacente y no simplemente observación, ya que podría enmascarar una patología grave. c) Indicar sulfato ferroso hasta normalizar el hematocrito y la ferremia: Si bien es necesario indicar sulfato ferroso, detener el tratamiento solo al normalizar estos parámetros sin investigar la causa es insuficiente. La anemia podría recurrir si la fuente de pérdida de hierro no se identifica y trata. d) Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional: Aunque 6 meses es un tiempo razonable para el tratamiento de la anemia ferropénica, omitir estudios adicionales en un hombre de 57 años es una omisión peligrosa, ya que se podría pasar por alto una causa importante de sangrado crónico. e) Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional: Un mes de tratamiento con sulfato ferroso es generalmente insuficiente para reponer las reservas de hierro y normalizar completamente los parámetros, y la omisión de estudios adicionales es inadecuada para un hombre en este grupo etario.

PREGUNTA 14 **Respuesta: B**

Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

1.08.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La anemia ferropénica en una mujer postmenopáusica (70 años) debe considerarse como un signo de alarma y obliga a descartar una causa subyacente, siendo la principal causa la pérdida de sangre gastrointestinal. La colonoscopía es el examen de elección para evaluar el colon y descartar patología tumoral, pólipos sangrantes u otras lesiones que puedan estar causando el sangrado crónico. El sulfato ferroso oral es el tratamiento de primera línea para reponer los depósitos de hierro una vez que se ha descartado la causa del sangrado o se está en proceso de investigación. La guía clínica del MINSAL de "Atención Integral de Salud de las Personas Adultas" hace hincapié en la importancia de investigar la causa de la anemia ferropénica en adultos mayores. Análisis de distractores: A: Observar evolución: Esta opción es incorrecta porque la anemia ferropénica en una paciente de 70 años requiere una investigación activa de la causa subyacente, no simplemente observación. Demorar la investigación podría retrasar el diagnóstico de una enfermedad grave, como un cáncer de colon. C: Indicar aporte oral de hierro, con hierro maltosado y solicitar recuento de reticulocitos mensual: Si bien el hierro maltosado es una alternativa al sulfato ferroso, esta opción ignora la necesidad de investigar la causa de la anemia en esta paciente. Solicitar recuento de reticulocitos es útil para evaluar la respuesta al tratamiento, pero no aborda el problema principal: identificar la fuente de la deficiencia de hierro. D: Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional: Administrar hierro sin investigar la causa subyacente es un error grave. Podría enmascarar una patología importante y retrasar su diagnóstico. Se debe descartar sangrado digestivo antes de asumir que la anemia se debe a una simple deficiencia nutricional. E: Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional: Al igual que la opción D, esta es incorrecta porque ignora la necesidad de investigar la causa de la anemia en esta paciente. Un mes de tratamiento con hierro es insuficiente para resolver la deficiencia, y no aborda la causa del problema.

PREGUNTA 15 **Respuesta: E**

Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La anemia por enfermedad crónica (AEC), también conocida como anemia de la inflamación, se caracteriza por una respuesta alterada a la eritropoyesis y una menor disponibilidad de hierro, secundaria a un proceso inflamatorio crónico. El mecanismo principal implica la acción de citoquinas proinflamatorias, como la interleucina-6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), que interfieren con la producción de eritropoyetina, disminuyen la respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina, aumentan la hepcidina (que bloquea la absorción y liberación de hierro) y acortan la vida útil de los glóbulos rojos. Por lo tanto, el abordaje terapéutico más efectivo y fundamental consiste en identificar y tratar la enfermedad de base que está generando la inflamación crónica. Al controlar o resolver la causa subyacente, se reduce la respuesta inflamatoria, se normalizan los niveles de hepcidina y se restaura la eritropoyesis eficaz. La resolución de la inflamación crónica permite que los mecanismos fisiológicos para la producción de glóbulos rojos se reanuden de manera adecuada. Esto implica una mejor absorción y utilización del hierro, una mayor sensibilidad de la médula ósea a la eritropoyetina endógena y una vida útil más prolongada de los eritrocitos. En muchos casos, una vez que la enfermedad de base está bien controlada, la anemia se resuelve espontáneamente o con medidas de soporte mínimas. Es crucial destacar que las otras opciones de tratamiento abordan síntomas o mecanismos específicos de la anemia, pero sin tratar la causa raíz, su eficacia es limitada y transitoria. Análisis de distractores: a) Eritropoyetina subcutánea: Si bien la eritropoyetina (EPO) puede ser útil en ciertos tipos de anemia, incluyendo algunas formas de AEC, su eficacia es limitada si la inflamación crónica persiste y los niveles de hepcidina son elevados. La EPO estimula la médula ósea a producir glóbulos rojos, pero si el hierro no está disponible o la médula ósea está suprimida por la inflamación, el tratamiento será inefectivo o requerirá dosis muy elevadas. Por lo tanto, no es el tratamiento de primera línea ni el más fundamental. b) Transfusiones periódicas: Las transfusiones de glóbulos rojos son una medida de soporte para corregir rápidamente la anemia y sus síntomas, pero no tratan la causa subyacente. Son una opción en casos de anemia severa sintomática, pero no resuelven el problema de fondo y conllevan riesgos y costos asociados. No son el tratamiento habitual ni el principal para la AEC. c) Hierro y Folatos por vía oral: El hierro y los folatos son cofactores esenciales para la producción de glóbulos rojos. Sin embargo, en la AEC, la disponibilidad de hierro está comprometida por el aumento de la hepcidina. La suplementación oral de hierro puede ser ineficaz o de baja eficacia debido a la inhibición de su absorción. Si bien puede ser útil en algunos casos después de tratar la enfermedad de base o en presencia de deficiencia concomitante, no es el tratamiento primario. Los folatos, por su parte, son importantes pero la deficiencia de folato raramente es la causa principal de la AEC. d) Corticoides: Los corticoides son inmunosupresores y antiinflamatorios. Pueden ser útiles en anemias secundarias a enfermedades autoinmunes o inflamatorias específicas donde los corticoides son parte del tratamiento de esa patología. Sin embargo, no son un tratamiento generalizado para todas las anemias por enfermedades crónicas y su uso indiscriminado sin tratar la causa específica puede tener efectos secundarios importantes. No abordan directamente los mecanismos fisiopatológicos de la mayoría de las AEC.

PREGUNTA 16 **Respuesta: D**

Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La anemia por enfermedad crónica (AEC), también conocida como anemia de la inflamación, es la causa más común de anemia en pacientes hospitalizados y una de las más frecuentes en la población general. Se caracteriza por una anemia normocítica, aunque puede volverse microcítica en etapas avanzadas. El perfil de hierro describe una "ferremia baja" (hierro sérico bajo), "transferrina baja" (capacidad total de fijación de hierro o TIBC baja) y "ferritina elevada". Esta combinación es diagnóstica de AEC. La ferritina elevada indica que las reservas de hierro en el cuerpo son adecuadas o incluso altas; sin embargo, el hierro no está disponible para la eritropoyesis debido a la inflamación. Las citoquinas inflamatorias, como la interleucina-6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), inducen la producción hepática de hepcidina. La hepcidina es una hormona clave que regula el metabolismo del hierro, al degradar la ferroportina, la principal proteína transportadora de hierro en la membrana celular. Esto resulta en una menor liberación de hierro de los macrófagos y enterocitos hacia la circulación, lo que explica el hierro sérico bajo y la transferrina baja (ya que la transferrina se une al hierro disponible en sangre). A pesar del hierro sérico bajo, la ferritina está elevada porque es una proteína de fase aguda, incrementada por la inflamación, y refleja las reservas corporales de hierro en lugar de la disponibilidad para la eritropoyesis. Análisis de distractores: a) Anemia hemolítica: Se caracteriza por la destrucción prematura de los glóbulos rojos. El perfil de hierro típicamente mostraría niveles de hierro sérico elevados (debido a la liberación de hierro de los glóbulos rojos destruidos), ferritina normal o elevada, y transferrina normal o elevada. La bilirrubina indirecta también estaría elevada. b) Anemia por déficit de folatos: Es una anemia megaloblástica, por lo que los glóbulos rojos serían macrocíticos (VCM elevado). El perfil de hierro sería variable, pero no presentaría esta combinación específica de ferritina elevada con hierro y transferrina bajos. c) Anemia ferropénica: Se caracteriza por una deficiencia de hierro. El perfil de hierro mostraría típicamente hierro sérico bajo, transferrina alta (aumentada para intentar captar más hierro) y ferritina baja (reflejando las bajas reservas de hierro). Además, la anemia ferropénica suele ser microcítica (VCM bajo). e) Talasemia: Es un trastorno hereditario de la síntesis de hemoglobina. Las talasemias menores suelen cursar con anemia microcítica hipocrómica con un perfil de hierro normal. Las talasemias mayores pueden tener sobrecarga de hierro, pero la presentación clínica y los otros marcadores serían diferentes. El hierro sérico y la ferritina suelen ser elevados en formas severas de talasemia por transfusiones, pero la transferrina no se vería consistentemente baja.

PREGUNTA 17 **Respuesta: A**

1.08.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

La aplasia medular idiopática se caracteriza por la falla de la médula ósea en producir células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas), lo que lleva a pancitopenia. El trasplante de médula ósea (TMO) alogénico, utilizando un donante compatible (idealmente un hermano HLA idéntico), es el tratamiento curativo de elección, especialmente en pacientes jóvenes. El TMO restaura la función hematopoyética normal al reemplazar las células madre defectuosas del paciente con células madre sanas del donante. En pacientes que no son elegibles para TMO (por edad, comorbilidades o falta de un donante compatible), o como puente al trasplante, se puede utilizar inmunosupresión con globulina antitimocítica (ATG) y ciclosporina, pero el TMO ofrece la mejor posibilidad de cura a largo plazo. Por lo tanto, el TMO es superior a las otras opciones terapéuticas en la mayoría de los casos de aplasia medular idiopática. Análisis de distractores: b) **Quimioterapia combinada:** La quimioterapia se utiliza para erradicar células malignas, pero no aborda la causa subyacente de la aplasia medular. De hecho, puede empeorar la condición al suprimir aún más la médula ósea. c) **Radioterapia:** La radioterapia también es un tratamiento para enfermedades malignas, no para la aplasia medular. Al igual que la quimioterapia, puede dañar aún más la médula ósea. d) **Cloramfenicol:** El cloramfenicol es un antibiótico que, paradójicamente, se ha asociado con aplasia medular en algunos casos. Por lo tanto, su uso estaría contraindicado. e) **No tiene tratamiento:** La aplasia medular idiopática sí tiene tratamiento, y el trasplante de médula ósea es el tratamiento más eficaz y curativo. Ignorar esta condición llevaría a complicaciones graves e incluso la muerte.

PREGUNTA 18 **Respuesta: A**

1.08.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

La respuesta correcta es la opción (a) Idiopática. La aplasia medular es una condición grave caracterizada por la insuficiencia de la médula ósea para producir suficientes células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). En la mayoría de los casos, la causa subyacente de la aplasia medular no puede ser identificada. A esto se refiere el término "idiopática", que significa de causa desconocida. Se estima que entre el 50% y el 75% de los casos de aplasia medular son idiopáticos. Aunque la aplasia medular puede ser secundaria a diversos factores, la etiología idiopática es, con diferencia, la más común. Se postula que estas formas idiopáticas podrían tener un origen autoinmune, donde el propio sistema inmunológico del paciente ataca y daña las células madre hematopoyéticas en la médula ósea. Sin embargo, la confirmación definitiva de este mecanismo en todos los casos idiopáticos sigue siendo un área de investigación activa en hematología. Análisis de distractores: b) Secundaria a fármacos: Si bien algunos fármacos (como la quimioterapia, ciertos antibióticos o antiepilépticos) pueden causar supresión medular, no son la causa más frecuente de aplasia medular en general. La mayoría de los casos de aplasia medular no se asocian a la exposición a medicamentos. c) Secundaria a infecciones virales: Las infecciones virales, especialmente virus como el parvovirus B19, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus o la hepatitis, pueden estar asociadas a la aplasia medular en algunos casos. Sin embargo, la contribución de las infecciones virales a la etiología total de la aplasia medular es menor que la de los casos idiopáticos. d) Congénita: Las aplasias medulares congénitas, como la anemia de Fanconi o la disqueratosis congénita, son causas importantes en la población pediátrica, pero representan una minoría de todos los casos de aplasia medular a nivel global, siendo mucho menos comunes que las idiopáticas en adultos. e) Invasión tumoral: La infiltración de la médula ósea por células tumorales (metástasis o leucemias) puede llevar a una insuficiencia medular, pero esto se clasifica de manera diferente a la aplasia medular primaria. En la aplasia medular idiopática, la médula ósea está hipocelular y sin infiltración tumoral significativa.

PREGUNTA 19 **Respuesta: D**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU

El Púrpura Trombocitopénico Trombótico (PTT) es una microangiopatía trombótica grave, caracterizada por una deficiencia severa de la enzima ADAMTS13. Esta enzima es responsable de cortar los multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand (FvW). En su ausencia, estos multímeros se acumulan en la circulación, provocando la agregación plaquetaria espontánea y la formación de microtrombos en la microvasculatura de múltiples órganos, principalmente el cerebro y los riñones. Esto conduce a la péntada clásica (aunque no siempre completa) de trombocitopenia por consumo, anemia hemolítica microangiopática (con esquistocitos en el frotis de sangre), fiebre, disfunción neurológica e insuficiencia renal. La plasmaféresis (o recambio plasmático) es el tratamiento de elección y la medida más eficaz porque aborda directamente la fisiopatología de la enfermedad desde dos frentes. Primero, elimina del plasma del paciente los componentes patogénicos: los autoanticuerpos inhibidores de ADAMTS13 (en la forma autoinmune, que es la más común en adultos) y los multímeros ultragrandes del FvW. Segundo, al reponer el plasma extraído con plasma fresco congelado de donantes, se suministra la enzima ADAMTS13 funcional que el paciente no tiene. Este tratamiento debe iniciarse de forma urgente ante la sospecha clínica, ya que ha demostrado reducir la mortalidad del 90% a menos del 20%. La insuficiencia renal aguda (IRA) es una complicación frecuente y grave del PTT debido a la trombosis de la microvasculatura renal. Cuando la IRA es severa (oligoanuria, uremia, hiperkalemia refractaria o sobrecarga de volumen), el soporte dialítico se vuelve indispensable para mantener la homeostasis mientras la plasmaféresis resuelve la causa subyacente. Por lo tanto, la combinación de plasmaféresis (tratamiento específico) y soporte dialítico (tratamiento de soporte para la complicación más grave) constituye el manejo más completo y eficaz para un paciente con PTT grave. Análisis de distractores: **a) Corticoides orales:** Los corticoides son parte del tratamiento del PTT autoinmune, ya que ayudan a suprimir la producción de autoanticuerpos contra ADAMTS13. Sin embargo, su efecto no es inmediato y, como monoterapia, son insuficientes para controlar la fase aguda y potencialmente mortal de la enfermedad. Se utilizan como terapia adyuvante a la plasmaféresis, no como tratamiento principal. **b) Corticoides + inmunosupresores endovenosos:** Esta combinación (por ejemplo, con Rituximab) es una estrategia terapéutica importante, especialmente en casos refractarios o para prevenir recaídas. Al igual que los corticoides solos, su objetivo es suprimir la respuesta autoinmune, pero no es el tratamiento de primera línea más eficaz para la emergencia aguda, que requiere la eliminación inmediata de los factores patogénicos y la reposición de la enzima. **c) Soporte transfusional:** Aunque los pacientes presentan trombocitopenia severa, la transfusión de plaquetas está generalmente contraindicada. Se considera que "añade combustible al fuego", ya que las nuevas plaquetas pueden ser rápidamente consumidas en la formación de nuevos microtrombos, empeorando la isquemia tisular. Solo se considera en casos de hemorragia activa que ponga en riesgo la vida. La transfusión de glóbulos rojos sí es necesaria para manejar la anemia sintomática, pero es una medida de soporte, no el tratamiento de la enfermedad. **e) Reposición de agua y electrolitos por vía endovenosa:** Esta es una medida de soporte básico fundamental en cualquier paciente crítico, especialmente con insuficiencia renal. Sin embargo, no hace nada para tratar la causa subyacente del PTT. Es una terapia de sostén necesaria, pero de ninguna manera es el tratamiento más eficaz.

PREGUNTA 20 **Respuesta: D**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU

La anemia hemolítica se caracteriza por una destrucción prematura de los glóbulos rojos (eritrocitos), lo que conduce a una serie de hallazgos de laboratorio. Uno de los mecanismos clave en la hemólisis es la liberación de hemoglobina en el plasma, que luego es metabolizada a bilirrubina. Dado que la hemoglobina se procesa principalmente en el hígado y el bazo, el aumento de la bilirrubina en la sangre tiende a ser predominantemente indirecta (no conjugada) antes de ser procesada por el hígado. La destrucción de eritrocitos también libera lactato deshidrogenasa (LDH), una enzima intracelular, que se eleva significativamente en la sangre como marcador de daño celular. Para compensar la pérdida de glóbulos rojos, la médula ósea aumenta la producción de nuevos eritrocitos, lo que se manifiesta como una elevación de los reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros. La presencia de esquistocitos, que son fragmentos de glóbulos rojos deformados, es característica de la hemólisis mecánica, que ocurre en ciertas anemias hemolíticas (como la coagulación intravascular diseminada o la microangiopatía trombótica). La haptoglobina es una proteína producida por el hígado que se une a la hemoglobina libre circulante. En condiciones normales, la hemoglobina liberada por la degradación fisiológica de los glóbulos rojos es captada por la haptoglobina. Sin embargo, en la anemia hemolítica, la cantidad de hemoglobina libre excede la capacidad de unión de la haptoglobina. Cuando los complejos haptoglobina-hemoglobina se forman en exceso, son rápidamente eliminados del torrente sanguíneo por el sistema reticuloendotelial. Por lo tanto, en la anemia hemolítica, los niveles de haptoglobina se encuentran disminuidos o indetectables debido a su consumo por la hemoglobina libre. Análisis de distractores: a) Bilirrubina elevada, de predominio indirecto: Incorrecta. Como se explicó, la destrucción de glóbulos rojos en la anemia hemolítica libera hemoglobina que se metaboliza a bilirrubina, siendo predominantemente indirecta. b) LDH muy aumentada: Incorrecta. La LDH es una enzima intracelular que se libera a la circulación cuando los glóbulos rojos se destruyen, por lo que se eleva significativamente en la anemia hemolítica. c) Presencia de esquistocitos: Incorrecta. Los esquistocitos son fragmentos de glóbulos rojos que se observan al microscopio y son indicativos de hemólisis mecánica, un tipo de anemia hemolítica. e) Elevación de los reticulocitos: Incorrecta. La anemia hemolítica estimula a la médula ósea a producir más glóbulos rojos para compensar la destrucción, lo que resulta en un aumento de los reticulocitos.

PREGUNTA 21 **Respuesta: C**

Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tanto por la afectación neurológica, como por la pancitopenia con VCM tan elevado, es una anemia perniciosa, por déficit de B12.

PREGUNTA 22 **Respuesta: B**

Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La anemia megaloblástica es un tipo de anemia caracterizada por la presencia de eritrocitos (glóbulos rojos) anormalmente grandes (macrocitos) y precursores en la médula ósea también de gran tamaño (megaloblastos). Esto se debe fundamentalmente a una alteración en la síntesis de ADN durante la eritropoyesis, causada con mayor frecuencia por deficiencia de vitamina B12 (cobalamina) o folato. La anemia perniciosa es una causa específica de deficiencia de vitamina B12, donde el sistema inmunitario ataca las células parietales del estómago. Estas células son responsables de producir el factor intrínseco, una proteína esencial para la absorción de la vitamina B12 en el íleon terminal. Sin factor intrínseco, la vitamina B12 no se absorbe adecuadamente, lo que lleva a la anemia megaloblástica. Por lo tanto, la anemia perniciosa directamente causa la deficiencia de vitamina B12 necesaria para la síntesis normal de ADN en las células precursoras de la sangre, resultando en la anemia megaloblástica. Esta relación causa-efecto directa convierte a la anemia perniciosa en la respuesta correcta a la pregunta. Otras condiciones pueden contribuir a la deficiencia de B12 o folato, pero la anemia perniciosa es una causa clásica e intrínseca de deficiencia de B12 debido a la autoinmunidad contra las células parietales. Análisis de distractores: a) **Pancreatectomía total:** Si bien la pancreatectomía total puede afectar la absorción de nutrientes en general debido a la pérdida de enzimas pancreáticas, no es una causa directa ni común de anemia megaloblástica. La mala absorción de nutrientes, incluyendo folato, podría ocurrir, pero no es el mecanismo primario. c) **Gastrinoma:** Un gastrinoma es un tumor que secreta gastrina, lo que lleva a una hipersecreción de ácido gástrico. Esto puede causar úlceras pépticas severas, pero no afecta directamente la absorción de vitamina B12 ni folato. d) **Enfermedad de Crohn:** La enfermedad de Crohn puede causar anemia megaloblástica si afecta el íleon terminal, que es el sitio de absorción de la vitamina B12 en presencia del factor intrínseco. Sin embargo, no *produce* directamente la anemia megaloblástica; sino que la mala absorción secundaria a la enfermedad es la causa. Por lo tanto, si bien puede ser una causa indirecta, no es la respuesta más precisa. e) **Déficit de vitamina B1:** El déficit de vitamina B1 (tiamina) causa beriberi o síndrome de Wernicke-Korsakoff, que son trastornos neurológicos. No causa anemia megaloblástica.

PREGUNTA 23 **Respuesta: B**

Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Tiene una anemia con VCM 110, es decir megaloblástica, por eso es por déficit de B12, causada en primer lugar por la anemia perniciosa. El déficit de folatos también podría ser una alternativa aceptable, pero los folatos son B9.

PREGUNTA 24 **Respuesta: D**

Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Anemia megaloblástica

PREGUNTA 25 **Respuesta: A**

Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Tiene una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. El VCM tan elevado la sugiere fuertemente. Tanto anemia hemolítica como el déficit de B12 pueden tener VCM elevado, hiperbilirrubinemia indirecta y LDH elevada, pero los reGculocitos bajos son incompaGbles con una anemia hemolítica. Dada la gravedad que Gene, con hemoglobina bajo 7 g/dl, probablemente requiere de una transfusión de glóbulos rojos, además del tratamiento con vitamina B12 intramuscular. La causa más frecuente de déficit de vitamina B12 es la anemia perniciosa, de origen autoinmune, con anticuerpos contra las células parietales gástricas, que hace que no se produzca el “factor intrínseco”, necesario para la absorción de B12. Por ello, se debe suplementar por vía intramuscular y no oral. En cambio, el déficit de B12 asociado a dietas vegetarianas y veganas sí se trata por vía oral.

PREGUNTA 26 **Respuesta: A**

Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Tiene un déficit de B12, por baja ingesta (dieta vegana). La anemia macrocítica y megaloblástica (VCM > 108) la sugiere fuertemente.

PREGUNTA 27 **Respuesta: C**

Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Es un clásico déficit de B12, con el compromiso neurológico y hematológico (pancitopenia, con VCM elevado). La LDH y la bilirrubina indirecta se elevan por la mielopoyesis inefectiva, al igual que en las anemias hemolíticas. Que el VCM sea mayor a 108 se conoce como anemia megaloblástica. Finalmente, la etiología más probable, en este caso, es una anemia perniciosa (enfermedad autoinmune contra las células parietales gástricas, que secretan el factor intrínseco, que permite la absorción de B12).

PREGUNTA 28 **Respuesta: B**

Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Gastrectomía es la causa (falta factor intrínseco y no se absorve la B12). Tiene además la anemia megalobástica y la neuropatía, encefalopatía y probable degeneración combinada subaguda de la médula (todo causado por falta de B12).

PREGUNTA 29 **Respuesta: C**

Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una anemia hemolítica clásica, probablemente autoinmune (AHAI). Orientan la anemia aguda y severa, con hiperbilirrubinemia indirecta, elevación de LDH. El VCM se puede elevar, por aumento de los reGculocitos. Los microesferocitos se ven en la AHAI, por el daño que sufren los glóbulos; en cambio, la microesferocitosis familiar suele ser un cuadro crónico, menos grave, con esplenomegalia y exacerbación durante los cuadros agudos. La prueba de Coombs directo está positiva en la AHAI y negativa en la mayoría de las otras causas de hemólisis.

PREGUNTA 30 **Respuesta: D**

Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la D) Corticoides. La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) es una condición donde el sistema inmunitario del individuo ataca y destruye sus propios glóbulos rojos. El tratamiento de primera línea para la AHAI, particularmente la variedad cálida (anticuerpos IgG), consiste en inmunosupresión. Los corticoides, como la prednisona, actúan suprimiendo la respuesta inmune y disminuyendo la producción de autoanticuerpos que causan la hemólisis. La dosis inicial suele ser alta y luego se reduce gradualmente según la respuesta del paciente. La base del tratamiento con corticoides reside en su capacidad de reducir la actividad del sistema reticuloendotelial, disminuyendo la captura y destrucción de los glóbulos rojos sensibilizados por autoanticuerpos en el bazo. Otros tratamientos, como la esplenectomía o el uso de inmunosupresores más potentes (rituximab, azatioprina, etc.), se reservan para casos refractarios a los corticoides. Análisis de distractores: A) Eritropoyetina subcutánea: La eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Si bien podría ayudar a compensar la anemia, no aborda la causa subyacente de la hemólisis (el ataque autoinmune) y sería ineficaz en presencia de una destrucción acelerada de glóbulos rojos. B) Transfusiones periódicas: Las transfusiones pueden ser necesarias para estabilizar al paciente en casos graves de anemia, pero son solo una medida de soporte y no tratan la causa de la hemólisis. Además, las transfusiones repetidas conllevan riesgos como la aloinmunización y la sobrecarga de hierro. C) Hierro y Folatos por vía oral: El hierro y los folatos son importantes para la producción de glóbulos rojos, pero no son el tratamiento principal para la AHAI. Aunque la hemólisis crónica puede llevar a la deficiencia de folato, la administración de hierro no es apropiada a menos que exista una deficiencia documentada, ya que en la AHAI la médula ósea está intentando producir glóbulos rojos a una velocidad acelerada y frecuentemente no hay carencia de hierro. E) Trasplante de médula ósea: El trasplante de médula ósea es un tratamiento agresivo que se reserva para casos muy raros y refractarios de AHAI, generalmente aquellos asociados a trastornos inmunitarios graves o cuando otras terapias han fallado. No es el tratamiento de primera línea.

PREGUNTA 31 **Respuesta: D**

Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es (D) Reticulocitos bajos. En una anemia hemolítica autoinmune (AHAI), el cuerpo está destruyendo glóbulos rojos de forma acelerada. Como respuesta a esta destrucción, la médula ósea intenta compensar produciendo más glóbulos rojos. Por lo tanto, se espera encontrar un aumento en el número de reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros, en la sangre periférica. Un recuento bajo de reticulocitos en el contexto de una anemia hemolítica sugiere que la médula ósea no está respondiendo adecuadamente a la demanda, lo cual es incompatible con la patogénesis de la AHAI. Análisis de distractores: a) Prueba de Coombs directa positiva: La prueba de Coombs directa es fundamental para el diagnóstico de AHAI. Detecta anticuerpos o complemento unidos a la superficie de los glóbulos rojos, lo que indica que están siendo atacados por el sistema inmunológico. Por lo tanto, un Coombs directo positivo es altamente compatible con AHAI. b) Haptoglobina baja: La haptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina libre liberada durante la hemólisis. En la AHAI, la hemólisis intravascular y extravascular consume haptoglobina, lo que resulta en niveles bajos en sangre. Por lo tanto, la haptoglobina baja es compatible con AHAI. c) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto: La hemólisis produce un aumento en la degradación de la hemoglobina, generando bilirrubina. La mayor parte de esta bilirrubina es no conjugada (indirecta) antes de ser procesada en el hígado. Por lo tanto, la hiperbilirrubinemia de predominio indirecto es una característica esperada en la AHAI. e) Macrocitosis: En muchas anemias hemolíticas, especialmente aquellas con una respuesta medular activa, los reticulocitos, que son más grandes que los glóbulos rojos maduros, pueden contribuir a un aumento del volumen corpuscular medio (VCM), resultando en macrocitosis. Si bien no es universal en todas las AHAI, es una alteración compatible.

PREGUNTA 32 **Respuesta: D**

Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Parece una anemia hemolítica. Si bien suelen no tener coluria (ya que la Bili es indirecta), puede que sea hemoglobinuria (también oscurece la orina). Se debe empezar con el hemograma y reticulocitos. Luego se pedirá el Coombs directo.

PREGUNTA 33 **Respuesta: E**

Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presentación clínica de astenia, fiebre, orinas oscuras y palidez, junto con los hallazgos del hemograma (hematocrito bajo, hemoglobina baja, VCM elevado y abundantes reticulocitos y esquistocitos en el frotis) sugiere fuertemente una anemia hemolítica. Los esquistocitos, en particular, son fragmentos de glóbulos rojos que se forman cuando estos son destruidos mecánicamente en la circulación, lo cual es característico de la microangiopatía hemolítica. La presencia de reticulocitos elevados indica una respuesta medular aumentada a la pérdida de glóbulos rojos, lo que es consistente con hemólisis. La prueba de Coombs directo (PCD) es crucial en este escenario porque detecta anticuerpos o complemento adheridos a la superficie de los glóbulos rojos, que son la causa subyacente de la hemólisis autoinmune. Un resultado positivo en la PCD orientaría hacia una anemia hemolítica autoinmune como causa principal, guiando el diagnóstico y tratamiento posterior. Análisis de distractores: a) Solicitar perfil de hierro: Si bien la deficiencia de hierro causa anemia, típicamente resulta en una anemia microcítica e hipocrómica (VCM bajo), lo cual no es el caso aquí ya que el VCM está elevado (macrocitosis). Por lo tanto, el perfil de hierro no es la prueba más urgente ni la que explicaría la presencia de esquistocitos. b) Solicitar niveles de vitamina B12 y folatos: Las deficiencias de vitamina B12 y folatos causan anemia megaloblástica, que se caracteriza por un VCM elevado, similar a este caso. Sin embargo, no explican la presencia de esquistocitos ni la hemólisis activa que parece estar ocurriendo. Aunque podrían ser causas de macrocitosis, la evidencia de hemólisis microangiopática hace que la PCD sea la prioridad. c) Solicitar biopsia de médula ósea: La biopsia de médula ósea es útil para evaluar la producción de células sanguíneas y diagnosticar trastornos de la médula ósea. Si bien podría ser necesaria en etapas posteriores del diagnóstico si la hemólisis no se explica por otras causas, no es la prueba inicial más adecuada ante la fuerte sospecha de hemólisis autoinmune, como lo indica la presencia de esquistocitos y la necesidad de determinar si hay anticuerpos. d) Solicitar pruebas de coagulación: Las pruebas de coagulación evalúan la cascada hemostática y los trastornos de la coagulación. Si bien una coagulopatía severa podría llevar a complicaciones hemorrágicas, no explica directamente la anemia hemolítica con esquistocitos. La presencia de esquistocitos apunta más a una destrucción mecánica de glóbulos rojos que a un problema de coagulación primaria, aunque condiciones como la Púrpura Trombocitopénica Trombotica (PTT) involucran tanto hemólisis como trombocitopenia y pueden tener alteraciones en la coagulación. Sin embargo, la PCD es el paso más directo para investigar la causa autoinmune de la hemólisis.

PREGUNTA 34 **Respuesta: E**

Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presentación clínica del paciente (lupus eritematoso sistémico, dolor abdominal, fiebre, orinas oscuras, ictericia, anemia, bilirrubina indirecta elevada y LDH elevada) sugiere fuertemente una hemólisis intravascular. La anemia con predominio de bilirrubina indirecta y LDH elevada apuntan a la destrucción de glóbulos rojos. En un paciente lúpico, la causa más probable de hemólisis es una anemia hemolítica autoinmune. Para confirmar este diagnóstico, es crucial determinar si los glóbulos rojos están siendo destruidos por anticuerpos. La prueba de Coombs (o prueba de antiglobulina directa) detecta anticuerpos o complemento unidos a la superficie de los glóbulos rojos. Un frotis sanguíneo puede revelar signos de hemólisis, como esquistocitos (fragmentos de glóbulos rojos) y esferocitos (glóbulos rojos esféricos sin la depresión central normal). La combinación de un frotis sanguíneo que muestre signos de hemólisis y una prueba de Coombs positiva confirmaría el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune. Análisis de distractores: a) **Biopsia de médula ósea:** Si bien la biopsia de médula ósea puede ser útil en el estudio de anemias, no es la prueba de primera línea para diagnosticar una anemia hemolítica autoinmune. Sería relevante si se sospechara falla medular o infiltración, pero no es lo que sugiere la clínica. b) **Frotis de médula ósea:** Similar a la biopsia, un frotis de médula ósea no es la prueba más directa para confirmar la hemólisis autoinmune. Aportaría información sobre la eritropoyesis. c) **Orina completa y ecografía abdominal:** La orina completa puede mostrar hemoglobinuria, lo que apoya la hemólisis, pero no confirma la etiología autoinmune. La ecografía abdominal se usaría para descartar otras causas de dolor abdominal, como colecistitis o esplenomegalia, pero no diagnostica la anemia hemolítica. d) **C3, C4 y anticuerpos anti-DNA doble hebra:** Si bien estos exámenes son importantes para el seguimiento del lupus y evaluar actividad de la enfermedad, no confirman directamente la anemia hemolítica autoinmune. Los niveles de complemento pueden estar disminuidos en lupus activo, pero no son específicos de la hemólisis.

PREGUNTA 35 **Respuesta: A**

Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presentación del paciente con anemia microcítica (VCM 70) y un perfil de hierro normal, sumado a la presencia de isocitosis en el frotis de sangre periférica, apunta fuertemente hacia una talasemia. La isocitosis, que se refiere a la variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos, es un hallazgo característico en las talasemias, especialmente en las formas heterocigóticas o menores, donde la producción de cadenas de globina es deficiente, llevando a la formación de eritrocitos más pequeños y pálidos, pero con una población heterogénea. A diferencia de la anemia ferropénica, donde el VCM bajo se asocia a una disminución del hierro, aquí el perfil de hierro es normal, descartando la deficiencia como causa principal. La talasemia es un trastorno hereditario de la síntesis de hemoglobina que se manifiesta típicamente con anemia microcítica, incluso con niveles de hierro normales. La talasemia se clasifica según el tipo de cadena de globina afectada (alfa o beta). En la talasemia beta, hay una producción reducida o ausente de cadenas beta de globina, lo que lleva a un desequilibrio en la producción de hemoglobina A. En la talasemia alfa, hay una producción reducida o ausente de cadenas alfa de globina. Independientemente del tipo, el resultado es una producción de eritrocitos ineficiente y su destrucción prematura, llevando a la anemia. La isocitosis observada en el frotis refleja la heterogeneidad en el tamaño de los glóbulos rojos debido a los diversos grados de defecto en la síntesis de hemoglobina. Análisis de distractores: b) Anemia ferropénica: Incorrecta porque el perfil de hierro (que incluiría ferritina, hierro sérico, transferrina y saturación de transferrina) es normal. La anemia ferropénica se caracteriza por un VCM bajo debido a la falta de hierro para la síntesis de hemoglobina, y el perfil de hierro estaría alterado con bajos niveles de hierro y ferritina. c) Anemia de enfermedades crónicas: Incorrecta porque, aunque puede cursar con microcitosis, típicamente se asocia a un metabolismo del hierro alterado (aumento de ferritina con hierro sérico bajo o normal y saturación de transferrina baja), lo cual no se observa aquí. Además, la isocitosis es menos característica. d) Anemia hemolítica crónica: Incorrecta porque en la anemia hemolítica, si bien hay anemia, el VCM suele ser normal o aumentado (si hay reticulocitosis significativa), y el frotis típicamente mostraría esferocitos, acantocitos o fragmentos de glóbulos rojos, no isocitosis como hallazgo principal. Los índices de LDH y bilirrubina indirecta estarían elevados. e) Hemocromatosis: Incorrecta porque la hemocromatosis es una sobrecarga de hierro, lo que llevaría a un aumento del hierro y la ferritina sérica. El paciente no presenta anemia microcítica típicamente, sino que puede tener anemia normocítica o macrocítica en etapas avanzadas, y la causa subyacente es el exceso de hierro, no su deficiencia o defecto de síntesis de globina.

PREGUNTA 36 **Respuesta: A**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)

La respuesta correcta es **a) Hemograma normal**. Durante el embarazo, el volumen plasmático aumenta en mayor proporción que la masa eritrocitaria, lo que conduce a una hemodilución fisiológica. Esto resulta en una disminución de la hemoglobina y el hematocrito, incluso en ausencia de deficiencia de hierro. Los valores de hemoglobina de 11 g/dl y hematocrito de 33% se consideran normales para una mujer embarazada de 20 semanas. Es importante destacar que los rangos de referencia para los valores hematológicos varían durante el embarazo, y estos valores se encuentran dentro del rango aceptable. El VCM normal (85 fL) apoya aún más la idea de que no hay una deficiencia de hierro significativa o talasemia que esté afectando el tamaño de los glóbulos rojos. La ausencia de otros hallazgos clínicos o antecedentes que sugieran otras causas de anemia refuerza la conclusión de que los valores son consistentes con la hemodilución fisiológica del embarazo. Si bien es importante monitorizar los niveles de hierro durante el embarazo, los valores presentados no son lo suficientemente bajos como para diagnosticar anemia en este contexto. Por lo tanto, el hemograma se considera normal para el estadio del embarazo. Análisis de distractores: * **b) Anemia ferropénica:** Aunque la anemia ferropénica es común durante el embarazo, el VCM es normal (85 fL). En la anemia ferropénica, típicamente se esperaría un VCM bajo (microcítico). Además, aunque los niveles de Hb y Hto son bajos, están dentro del rango aceptable para el embarazo (normalmente >11 g/dL en el segundo trimestre). * **c) Talasemia:** La talasemia también suele presentar un VCM bajo (microcitosis), aunque en portadores talasémicos puede ser normal o discretamente bajo. Además, no hay indicios clínicos o antecedentes que sugieran talasemia. * **d) Anemia por enfermedades crónicas:** Generalmente, la anemia por enfermedades crónicas se acompaña de otros hallazgos clínicos relacionados con la enfermedad subyacente, que no están presentes en este caso. El VCM puede ser normal o bajo, y no hay evidencia de una enfermedad crónica. * **e) Déficit de folatos:** El déficit de folatos causa anemia megaloblástica, que se caracteriza por un VCM elevado (macrocítico). El VCM normal en este caso descarta esta posibilidad.

BLOQUE 3 HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A** **Púrpuras vasculares**

1.08.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Púrpuras vasculares" (1.08.1.013), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 38 **Respuesta: A** **Trombopenia severa**

1.08.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Trombopenia severa" como urgencia clínica (1.08.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 39 **Respuesta: D**

Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

1.08.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La presentación de hemartrosis recurrentes (sangrado en las articulaciones) y hematomas profundos en un niño de 4 años es altamente sugestiva de un trastorno de la coagulación, específicamente un defecto en la vía intrínseca de la cascada de coagulación. El tiempo de protrombina activado (TTPA) es una prueba de laboratorio que evalúa precisamente la vía intrínseca y la vía común de la coagulación. Un TTPA prolongado indica una deficiencia o disfunción de uno o más factores de coagulación involucrados en estas vías. Las hemartrosis son una manifestación clásica de trastornos severos de la coagulación, como la hemofilia A (deficiencia del factor VIII) o la hemofilia B (deficiencia del factor IX), ambos de herencia ligada al cromosoma X y que cursan con un TTPA prolongado y un TP normal. Por lo tanto, con alta probabilidad, este niño presentará una alteración del TTPA debido a una deficiencia en la vía intrínseca de la coagulación, lo que conduce a su tendencia a sangrar excesivamente en articulaciones y tejidos profundos. Es importante destacar que aunque el tiempo de protrombina (TP) evalúa la vía extrínseca y la vía común, en las hemofilias típicas el TP suele ser normal. Las plaquetas y su función, así como el fibrinógeno, son evaluados por otras pruebas y, aunque pueden verse afectados secundariamente en algunas coagulopatías severas, la alteración primaria que explica estas manifestaciones clínicas se encuentra en los factores de coagulación medidos por el TTPA. Análisis de distractores: a) Alteración del recuento de plaquetas: Un recuento plaquetario anormal, como la trombocitopenia (bajo número de plaquetas) o la trombocitosis (alto número de plaquetas), causa principalmente sangrado a nivel cutáneo y de mucosas (petequias, púrpura), o trombosis en el caso de la trombocitosis. No son la causa principal de hemartrosis recurrente y hematomas profundos sin otras alteraciones plaquetarias evidentes. b) Alteración de las pruebas de agregación plaquetaria: Problemas en la agregación plaquetaria se manifiestan con sangrados de tipo petequial o equimótico superficial, sangrado de mucosas y prolongación del tiempo de sangría. Si bien pueden contribuir a un sangrado generalizado, no son la causa primaria de las hemartrosis severas que sugieren un defecto en la cascada de coagulación. c) Alteración de los niveles plasmáticos de fibrinógeno: El fibrinógeno (factor I) es fundamental en la vía común de la coagulación para formar el coágulo de fibrina. Niveles muy bajos de fibrinógeno (afibrinogenemia o hipofibrinogenemia) causan sangrado severo generalizado, incluyendo hemartrosis, pero se clasificarían dentro de las coagulopatías, y la prueba más sensible para detectar déficits en la vía intrínseca y común es el TTPA. Además, otras coagulopatías con TTPA prolongado son mucho más comunes. e) Alteración del TP: El tiempo de protrombina (TP) evalúa la vía extrínseca (factores VII) y la vía común (factores X, V, II, I). Un TP alterado sugiere deficiencias en estos factores, como se ve en la deficiencia de vitamina K, anticoagulación con warfarina, o coagulopatías como la deficiencia de factor VII. Las hemartrosis severas y la historia del niño son más características de déficits en la vía intrínseca, lo que lleva a un TTPA prolongado y un TP normal (en la mayoría de los casos de hemofilia).

PREGUNTA 40 **Respuesta: C**

Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

1.08.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La presentación de hematomas musculares espontáneos y hemartrosis recurrentes en un niño de 6 años, junto con equimosis ante traumas menores, sugiere una diátesis hemorrágica hereditaria. La respuesta correcta, el alargamiento del TTPA (tiempo de tromboplastina parcial activada), apunta hacia un defecto en la vía intrínseca o común de la cascada de coagulación. Las hemofilias (A y B) son las causas más comunes de hemorragias significativas en niños y se caracterizan por deficiencias en los factores VIII y IX, respectivamente. Ambos factores participan en la vía intrínseca de la coagulación, y su deficiencia resulta en un TTPA prolongado mientras que el tiempo de protrombina (TP), que evalúa la vía extrínseca, y el tiempo de sangría suelen ser normales. El TTPA evalúa la función de los factores de coagulación de la vía intrínseca (factores XII, XI, IX, VIII) y de la vía común (factores X, V, II, I). Un TTPA prolongado indica una anomalía en uno o más de estos factores. Dada la clínica de hemorragias profundas (hematomas, hemartrosis), la principal sospecha recae en las hemofilias. En estas patologías, la vía extrínseca (evaluada por el TP) y la hemostasia primaria (evaluada por el tiempo de sangría y el recuento plaquetario) son generalmente normales, lo que descarta otras causas de sangrado. Por lo tanto, el alargamiento del TTPA es el hallazgo más probable en este escenario clínico. Análisis de distractores: a) Disminución del recuento de plaquetas: Un recuento bajo de plaquetas (trombocitopenia) o una disfunción plaquetaria se manifestarían típicamente con sangrado de mucosas, petequias y equimosis en piel, que son más superficiales. Los hematomas musculares y las hemartrosis son menos comunes en trombocitopenias puras y más sugestivos de defectos en la coagulación. b) Alargamiento del tiempo de sangría: El tiempo de sangría es una medida de la hemostasia primaria, que depende de la función plaquetaria y la integridad de los vasos sanguíneos. Un tiempo de sangría prolongado se observa en trastornos plaquetarios o enfermedad de von Willebrand, pero no es la alteración principal en las hemofilias, que afectan la coagulación. d) Disminución del fibrinógeno: El fibrinógeno (factor I) es crucial para la formación del coágulo final. Una disminución severa del fibrinógeno (afibrinogenemia o hipofibrinogenemia) causaría un sangrado generalizado y prolongado. Sin embargo, las hemofilias no afectan directamente los niveles de fibrinógeno, sino los factores que activan la trombina, que a su vez convierte el fibrinógeno en fibrina. e) Alargamiento del tiempo de protrombina: El tiempo de protrombina (TP) evalúa la vía extrínseca de la coagulación (factores VII, X, V, II, I). Un TP prolongado sugiere un defecto en estos factores, como en la deficiencia de vitamina K, enfermedad hepática o deficiencia del factor VII. Las hemofilias afectan principalmente la vía intrínseca, dejando el TP generalmente normal.

PREGUNTA 41 **Respuesta: A**

Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

1.08.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

PTI: trombocitopenia aislada severa en niño sano post-viral, sin anemia hemolítica ni IRA (descarta SHU/PTT), sin blastos (descarta leucemia). El PTI pediátrico es autolimitado en el 80% en 6 meses. Tratamiento: observación si asintomático, IGIV o corticoides si hay sangrado.

PREGUNTA 42 **Respuesta: D**

Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

1.08.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Las petequias son pequeñas hemorragias puntiformes, menores a 3 mm, que se producen por la extravasación de sangre desde los capilares. Su presencia es altamente sugestiva de una alteración en la hemostasia primaria, que es el proceso inicial de formación del tapón plaquetario. Las causas de petequias incluyen trombocitopenia (disminución del número de plaquetas), disfunción plaquetaria, vasculitis o fragilidad capilar. La guía GES Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del MINSAL, por ejemplo, destaca las petequias como un hallazgo común en pacientes con trombocitopenia. Análisis de distractores: * **A: Alargamiento del TTPA:** El Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado (TTPA) evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación. Su alargamiento sugiere deficiencias en factores de coagulación como el VIII, IX, XI o XII, o la presencia de anticoagulantes lúpicos, apuntando a un problema en la hemostasia secundaria (coagulación), no primaria. * **B: Equímosis:** Las equímosis son hematomas más grandes, mayores a 1 cm, que también implican extravasación de sangre. Si bien pueden estar presentes en alteraciones de la hemostasia primaria (especialmente si son de aparición fácil y espontánea), también son comunes en alteraciones de la hemostasia secundaria y traumatismos. No son tan específicas para hemostasia primaria como las petequias. * **C: Antecedentes familiares de hemorragias:** Si bien los antecedentes familiares pueden sugerir un trastorno hemorrágico hereditario, no orientan específicamente a una alteración de la hemostasia primaria. Podrían indicar hemofilias (alteración de la hemostasia secundaria), enfermedad de von Willebrand (que afecta la función plaquetaria y al factor VIII), u otros trastornos. * **E: Hemartrosis:** La hemartrosis (sangrado intraarticular) es muy característica de las hemofilias, un trastorno de la hemostasia secundaria debido a la deficiencia de factores de coagulación (VIII o IX). No es un hallazgo típico de la alteración de la hemostasia primaria.

PREGUNTA 43 **Respuesta: E**

Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

1.08.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

En un paciente con Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI) crónica, de 55 años, que no responde a un tratamiento de 3 meses con esteroides, se considera la esplenectomía como la segunda línea de tratamiento de elección. La PTI crónica se caracteriza por la destrucción periférica de plaquetas mediada por anticuerpos. Los esteroides son la terapia de primera línea, pero en caso de refractariedad o dependencia, se deben considerar otras opciones. La esplenectomía, al extirpar el principal sitio de destrucción de plaquetas y el lugar de producción de anticuerpos, puede lograr una remisión sostenida en un alto porcentaje de pacientes. La decisión de la esplenectomía como segunda línea se basa en su eficacia y en la posibilidad de evitar tratamientos inmunosupresores crónicos que pueden tener efectos adversos significativos a largo plazo. Si bien existen otras opciones farmacológicas, la remisión obtenida con la esplenectomía suele ser más duradera y a menudo permite suspender la medicación. Es importante destacar que la esplenectomía debe ir acompañada de profilaxis contra infecciones encapsuladas debido al riesgo incrementado de sepsis post-esplenectomía. Análisis de distractores: a) Azatioprina: La azatioprina es un inmunosupresor que se utiliza como terapia de segunda o tercera línea en la PTI, pero generalmente después de considerar la esplenectomía o en pacientes en quienes la esplenectomía no es una opción viable. Su eficacia puede ser menor que la de la esplenectomía y requiere un seguimiento cuidadoso por sus efectos secundarios. b) Danazol: El danazol es un andrógeno sintético que puede ser útil en la PTI, particularmente en mujeres, pero no es la primera opción de segunda línea en un paciente refractario a esteroides. Su mecanismo de acción es complejo e incluye la supresión de la médula ósea y la reducción de la sensibilidad de los macrófagos a los anticuerpos. c) Inmunoglobulinas i.v. a altas dosis: Las inmunoglobulinas intravenosas (IVIg) se utilizan principalmente para aumentar rápidamente el recuento de plaquetas en situaciones agudas de sangrado o para preparaciones pre-esplenectomía. No son una terapia de segunda línea para la PTI crónica refractaria a esteroides, ya que su efecto es transitorio y su uso crónico es costoso y menos eficaz que otras opciones. d) Vincristina: La vincristina es un agente quimioterapéutico que puede utilizarse en la PTI, a menudo en combinación con otros fármacos o en casos dePTI severa o refractaria. Sin embargo, su uso como segunda línea de tratamiento aislado en la PTI crónica refractaria a esteroides no es la opción estándar, y su toxicidad puede ser una preocupación.

PREGUNTA 44 **Respuesta: D**

Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

1.08.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfermedad de Von Willebrand

PREGUNTA 45 **Respuesta: A**

Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

1.08.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario ligado al cromosoma X, que se caracteriza por la deficiencia de factores de coagulación específicos, principalmente el factor VIII (hemofilia A) o el factor IX (hemofilia B). La presentación clínica más clásica y sugestiva de hemofilia en un paciente masculino de 16 años es la presencia de hemartrosis (sangrado dentro de las articulaciones), especialmente en articulaciones de carga como las rodillas, de manera espontánea o tras traumatismos mínimos. Estas hemartrosis recurrentes pueden llevar a dolor crónico, inflamación y, a largo plazo, a daño articular severo, deformidades y limitación funcional. La edad de 16 años es común para que estas manifestaciones se vuelvan evidentes, dado que la acumulación de sangrados articulares se hace clínicamente significativa. La naturaleza espontánea de las hemartrosis es un hallazgo clave que distingue a la hemofilia de otros trastornos de la coagulación o plaquetarios. Si bien los traumatismos mínimos pueden desencadenar sangrado, la recurrencia sin un trauma aparente o con un trauma muy leve es altamente indicativa de una deficiencia severa de factores de coagulación. La afectación exclusiva o predominante de hombres, debido a la herencia ligada al cromosoma X, también refuerza la sospecha diagnóstica en este caso. Análisis de distractores: b) Paciente de sexo masculino y 14 años, que presenta epistaxis frecuentes, asociado a aparición de petequias y equimosis con pequeños golpes. Esta descripción es más sugestiva de un trastorno plaquetario (como trombocitopenia o disfunción plaquetaria) o de una coagulopatía adquirida que afecte la hemostasia primaria. Las petequias son sangrados puntiformes superficiales, característicos de problemas plaquetarios o vasculares. La hemofilia, al ser un defecto en la cascada de coagulación (hemostasia secundaria), se manifiesta típicamente con hematomas grandes (equimosis), sangrado profundo en articulaciones y músculos, y sangrados prolongados después de cortes o procedimientos, no tanto con petequias. c) Paciente de sexo femenino de 13 años, que presenta hematuria y artralgias, asociado a un púrpura de extremidades inferiores y hematoquezia. Si bien una paciente femenina podría ser portadora de hemofilia (lo que a veces puede causar síntomas leves), la combinación de hematuria, artralgias, púrpura y hematoquezia es más compatible con enfermedades autoinmunes (como el lupus eritematoso sistémico, que puede causar vasculitis y manifestaciones hematológicas), o con otras coagulopatías hereditarias menos comunes o adquiridas. Las artralgias son inespecíficas y pueden ocurrir en diversas condiciones. El púrpura puede ser de origen plaquetario, vascular o inducido por vasculitis. La hematuria y hematoquezia también pueden tener múltiples causas, incluyendo coagulopatías, pero la presentación completa no es la típica de hemofilia. d) Paciente de sexo femenino, de 18 años, que desde su infancia ha prensentado tendencia a presentar equimosis, sangra más de lo normal en procedimientos dentales y tiene reglas muy abundantes. Aunque las mujeres pueden ser portadoras de hemofilia y en raras ocasiones tener niveles de factor de coagulación lo suficientemente bajos como para presentar síntomas, esta descripción es más común en portadoras sintomáticas de hemofilia A o B, o en pacientes con enfermedad de von Willebrand (una de las coagulopatías hereditarias más comunes y que afecta a ambos sexos, con manifestaciones variables). Las reglas muy abundantes (menorragia) y la tendencia a equimosis son síntomas compatibles con trastornos de la hemostasia, pero la hemofilia clásica se presenta predominantemente en varones con hemartrosis profundas. e) Paciente de sexo masculino, de 5 años, que presenta un púrpura petequial generalizado, de 3 días de evolución, que empezó una semana después de una infección respiratoria alta. Este cuadro es altamente sugestivo de una Trombocitopenia Inmunológica (PTI) post-infecciosa en un niño. La PTI se caracteriza por la destrucción de plaquetas, lo que lleva a sangrado superficial en forma de petequias y equimosis. La aparición después de una infección viral es un antecedente típico de PTI. La hemofilia, en cambio, no se asocia típicamente con infecciones virales desencadenantes y su manifestación principal no son las petequias generalizadas.

PREGUNTA 46 **Respuesta:**

Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

1.08.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es Hemofilia. Los hematomas musculares espontáneos, las hemartrosis (sangrado en las articulaciones) y las equimosis fáciles ante traumas menores son características clásicas de la hemofilia, especialmente la hemofilia A (deficiencia de factor VIII) o la hemofilia B (deficiencia de factor IX). Estas enfermedades son hereditarias y afectan principalmente a varones, quienes heredan el cromosoma X afectado de sus madres portadoras. La gravedad de los síntomas varía dependiendo del nivel de factor de coagulación deficiente. La presentación a temprana edad, como en este niño de 6 años, es común en casos de hemofilia moderada a severa. La hemofilia se debe a una deficiencia en uno de los factores de coagulación necesarios para la formación del coágulo sanguíneo. Esta deficiencia conduce a una coagulación ineficaz y, por lo tanto, a sangrado prolongado o espontáneo. Las hemartrosis repetidas pueden causar daño articular crónico y discapacidad a largo plazo si no se tratan adecuadamente. El diagnóstico se confirma mediante pruebas de laboratorio que miden los niveles de factores de coagulación VIII y IX. Análisis de distractores: * **Púrpura trombocitoénico inmune (PTI):** Si bien el PTI causa sangrado, generalmente se manifiesta con petequias, púrpura (manchas pequeñas de sangrado en la piel) y sangrado mucocutáneo (sangrado nasal, gingival). Las hemartrosis son raras en PTI. El PTI se caracteriza por una disminución del número de plaquetas, lo cual no se menciona en el caso. * **Púrpura trombocitopénico trombótico (PTT):** El PTT es una emergencia médica rara que implica la formación de microtrombos en los vasos sanguíneos, lo que conduce a trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y disfunción orgánica. Se caracteriza por fiebre, alteraciones neurológicas, insuficiencia renal y anemia. No encaja con la presentación clínica del caso. * **Coagulación intravascular diseminada (CID):** La CID es un trastorno de la coagulación generalizado que se produce como complicación de otras enfermedades subyacentes graves (sepsis, traumatismos graves, cáncer). Implica la activación generalizada de la coagulación y la fibrinólisis, lo que lleva tanto a trombosis como a sangrado. No se presenta de forma espontánea en un niño sano. * **Enfermedad de Von Willebrand (EVW):** La EVW es un trastorno hemorrágico hereditario común que afecta la función del factor de Von Willebrand, que es importante para la adhesión de las plaquetas y el transporte del factor VIII. Generalmente se manifiesta con sangrado mucocutáneo (sangrado nasal, gingival, menstruaciones abundantes), pero las hemartrosis son menos comunes que en la hemofilia severa. La EVW suele diagnosticarse en la adolescencia o en la edad adulta, aunque a veces se puede presentar en la infancia.

PREGUNTA 47 **Respuesta: B**

Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

1.08.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una EvW clásico (alteración de hemostasia primaria: petequias y alveolorragia), con plaquetas normales (es disfunción plaquetaria) y puede alargar levemente el TTPA. La hemofilia alarga el TTPA pero tendría muchos más síntomas y hematomas, además de hemartrosis y sin petequias.

PREGUNTA 48 **Respuesta: A**

Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

1.08.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta muy difícil, porque tanto la hemofilia como la EvW producen epistaxis, equimosis y alveolorragia (epistaxis y alveolorragia son más de EvW). El alargamiento leve del TTPA también puede verse en ambos, aunque la palabra “leve” orienta más a EvW. El hematoma profundo orienta más a hemofilia y es el dato más fuerte como para elegirla, pero la EvW puede tenr hematomas y tipo 3 se caracteriza por tenerlos. Un caso como este está límite entre ambas. La hemofilia probablemente sería más grave, con síntomas desde la infancia y con hemartrosis y más hematomas.

PREGUNTA 49 **Respuesta: A**

Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

1.08.2.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Coagulopatía congénita sangrante" como urgencia clínica (1.08.2.003), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 50 **Respuesta: A**

Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

1.08.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La paciente presenta una fibrilación auricular (FA) con múltiples factores de riesgo tromboembólico, evidenciados por su antecedente de ACV isquémico, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, edad (68 años) y sexo femenino. Esto le confiere un puntaje CHA2DS2-VASc muy elevado (7 puntos: 1 por HTA, 1 por DM2, 2 por ACV previo, 1 por enfermedad vascular, 1 por edad 65-74, 1 por sexo femenino), lo que indica un riesgo muy alto de eventos cerebrovasculares isquémicos. El hecho de haber sufrido un ataque isquémico transitorio (AIT) mientras recibía aspirina, sumado a la FA crónica y una aurícula izquierda aumentada de tamaño, refuerza la insuficiencia de la terapia antiplaquetaria para la prevención de tromboembolismos de origen cardioembólico. La guía actual para pacientes con FA de alto riesgo como esta, recomienda encarecidamente la anticoagulación oral para la prevención de eventos tromboembólicos. Los antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol, o los anticoagulantes orales directos (DOACs), son significativamente más efectivos que la aspirina o la terapia antiplaquetaria dual en la prevención de eventos cardioembólicos. La opción A propone iniciar acenocumarol, un anticoagulante oral, lo cual es la estrategia más apropiada y basada en la evidencia para esta paciente. La mención de "terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular" es consistente con la práctica clínica, donde a menudo se utiliza heparina como puente para lograr una anticoagulación rápida mientras el acenocumarol alcanza su nivel terapéutico, especialmente en un contexto de un evento agudo como un AIT. Análisis de distractores: **b) Sustituiría la aspirina por clopidogrel:** El clopidogrel es un antiplaquetario, y la terapia antiplaquetaria es inferior a la anticoagulación oral para la prevención de eventos cardioembólicos en pacientes con FA de alto riesgo. **c) Añadiría clopidogrel a la aspirina:** La terapia antiplaquetaria dual (aspirina + clopidogrel) no es tan efectiva como la anticoagulación oral para la prevención de accidente cerebrovascular en FA y aumenta significativamente el riesgo de sangrado. **d) Duplicaría la dosis de aspirina:** Aumentar la dosis de aspirina no mejora la eficacia en la prevención de accidentes cerebrovasculares cardioembólicos y solo incrementa el riesgo de hemorragia. La aspirina no es la terapia adecuada para este mecanismo de ictus. **e) Antes de retirar la aspirina intentaría una nueva reversión farmacológica:** Aunque restaurar el ritmo sinusal es deseable, la paciente ya ha fallado a la cardioversión previamente (eléctrica y farmacológica), y aún si se lograra, los pacientes con FA de alto riesgo y antecedentes de ACV/AIT a menudo requieren anticoagulación independientemente del ritmo debido al riesgo residual y las alteraciones estructurales (aurícula izquierda aumentada). La prioridad es la prevención de eventos isquémicos mediante anticoagulación efectiva.

PREGUNTA 51 **Respuesta: A**

Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

1.08.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La respuesta correcta es la opción a) Alcohol y hepatitis C, ya que son las causas más prevalentes de daño hepático crónico en Chile y a nivel mundial, conduciendo a cirrosis y carcinoma hepatocelular. El consumo crónico y excesivo de alcohol es, sin lugar a dudas, una de las principales causas de enfermedad hepática crónica en Chile. La hepatopatía alcohólica abarca un espectro de enfermedades que van desde la esteatosis hepática (hígado graso), pasando por la hepatitis alcohólica, hasta la cirrosis y sus complicaciones, como la insuficiencia hepática y el carcinoma hepatocelular. La alta prevalencia de consumo de alcohol en Chile contribuye significativamente a la carga de esta enfermedad. La infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) es la otra gran causa de daño hepático crónico. El VHC persiste en el hígado, causando inflamación y fibrosis progresiva que puede tardar décadas en manifestarse clínicamente, pero que invariablemente lleva a cirrosis en un porcentaje significativo de pacientes. Aunque la prevalencia de VHC en la población general chilena no es tan alta como en otras regiones del mundo, sigue siendo una causa muy relevante de enfermedad hepática avanzada, trasplantes hepáticos y mortalidad asociada a hepatopatía crónica. La co-ocurrencia de consumo de alcohol y hepatitis C acelera significativamente la progresión del daño hepático. Análisis de distractores: * **b) Alcohol y hepatitis B**: Si bien el alcohol es correcto, la hepatitis B crónica (VHB) tiene una prevalencia mucho menor en Chile en comparación con la hepatitis C. Chile es un país de baja endemicidad para VHB, y la vacunación universal ha reducido aún más su impacto, por lo que no figura entre las dos causas *más frecuentes* de daño hepático crónico en el país, a diferencia de otras regiones del mundo. * **c) Alcohol y tumoral**: El término "tumoral" es muy inespecífico. Si bien el carcinoma hepatocelular es una complicación grave del daño hepático crónico, no es la *causa inicial* del daño. El cáncer de hígado se desarrolla en un hígado previamente dañado por alcohol, hepatitis viral u otras etiologías. Por lo tanto, no es una causa primaria de daño hepático crónico en el mismo sentido que el alcohol o un virus. * **d) Alcohol y NASH**: La esteatohepatitis no alcohólica (NASH, por sus siglas en inglés) es, de hecho, una causa creciente e importante de daño hepático crónico, estrechamente relacionada con la obesidad, diabetes y síndrome metabólico, enfermedades cuya prevalencia está en aumento en Chile. Sin embargo, históricamente y hasta las estadísticas más recientes que suelen ser la base de estas preguntas, la combinación de alcohol y hepatitis C ha sido considerada la más frecuente. Aunque NASH está ganando terreno rápidamente y en el futuro podría superar a HCV en algunas poblaciones, al momento de la formulación de la pregunta, HCV mantenía su posición como una de las causas principales junto con el alcohol. * **e) Alcohol y autoinmune**: Las enfermedades hepáticas autoinmunes (como la hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria) son causas importantes de daño hepático crónico, pero su prevalencia es significativamente menor que la del consumo de alcohol o la infección por hepatitis C. Son condiciones relativamente raras en comparación con las etiologías virales y metabólicas.

PREGUNTA 52 **Respuesta: D**

Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

1.08.2.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

ntídoto para los Cumarínicos: El antídoto para los cumarínicos o antagonistas de la vitamina K varía según la urgencia para revertir su efecto. Reversión inmediata: Se debe administrar plasma fresco congelado. Reversión no urgente: Se debe administrar vitamina K.

PREGUNTA 53 **Respuesta: E**

Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo

1.08.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Es una coagulación intravascular diseminada clásica.

PREGUNTA 54 **Respuesta: C**

Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo

1.08.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la c) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA). La heparina no fraccionada (HNF) ejerce su efecto anticoagulante potenciando la acción de la antitrombina III, que inhibe principalmente la trombina y el factor Xa. El TTPA es el examen de laboratorio que evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación, las cuales se ven afectadas por la acción de la HNF. El objetivo del control del TTPA es mantenerlo en un rango terapéutico, generalmente entre 1.5 y 2.5 veces el valor control, para asegurar una anticoagulación adecuada y minimizar el riesgo de complicaciones hemorrágicas. El TTPA permite monitorizar la respuesta individual del paciente a la HNF, ya que esta respuesta puede variar debido a factores como la edad, la función renal, el peso corporal y la presencia de otras enfermedades. La titulación de la dosis de HNF se realiza en base a los resultados del TTPA, buscando alcanzar el rango terapéutico definido. Análisis de distractores: a) Tiempo de protrombina (TP) e INR: El TP/INR evalúa la vía extrínseca de la coagulación y se utiliza principalmente para monitorizar la anticoagulación con warfarina (anticoagulantes orales). No es el examen de elección para monitorizar la HNF. b) Tiempo de trombina (TT): El TT evalúa directamente la conversión del fibrinógeno en fibrina por la trombina. Si bien la HNF afecta la actividad de la trombina, el TT es muy sensible a la presencia de heparina y no es útil para la monitorización rutinaria de la HNF. Se ve alterado incluso con dosis bajas de heparina, haciendo difícil la diferenciación de los niveles terapéuticos. d) Tiempo de sangría: El tiempo de sangría evalúa la función plaquetaria y no se utiliza para monitorizar la anticoagulación con heparina. e) No requiere control con exámenes: La anticoagulación con HNF requiere monitorización con exámenes de laboratorio debido a la variabilidad en la respuesta de los pacientes y el riesgo de complicaciones hemorrágicas si la anticoagulación no es adecuada.

BLOQUE 4 ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: A**

Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

1.08.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Era una leucemia aguda clásica.

PREGUNTA 56 **Respuesta: B**

Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

1.08.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es Leucemia Mieloide Aguda (LMA). La presentación clínica del paciente con astenia, fiebre ocasional, esplenomegalia y palidez es sugerente de una patología hematológica maligna. El hemograma revela una anemia moderada (Hcto: 29%, Hb: 9,2 g/dl) y una leucocitosis marcada (blancos: 43.000). El diferencial de leucocitos es crucial para el diagnóstico: un 95% de neutrófilos con una presencia significativa de promielocitos (74%) es altamente anormal. Los promielocitos son células inmaduras de la línea mieloide, y su gran cantidad, junto con la presencia de blastos (6%), indica una proliferación descontrolada de células mieloides inmaduras. Los promielocitos descritos con citoplasma abundante, núcleos bilobulados/plegados y gránulos gruesos, son características morfológicas típicas de promielocitos patológicos en el contexto de una LMA, especialmente en subtipos como la LMA M3 (Leucemia Promielocítica Aguda), aunque la descripción es generalizable a otros tipos de LMA. La presencia de blastos, células embrionarias anómalas, es un criterio diagnóstico definitorio para la LMA. Análisis de distractores: a) Leucemia mieloide crónica (LMC): La LMC se caracteriza típicamente por una leucocitosis marcada con una diferenciación mieloide madura, incluyendo presencia de todas las etapas de maduración (basales, mielocitos, metacitos, formas maduras), y usualmente no presenta un alto porcentaje de blastos. La LMC clásica tampoco muestra la predominancia de promielocitos patológicos observada en este caso. c) Mononucleosis infecciosa: La mononucleosis infecciosa es una infección viral (generalmente por el virus de Epstein-Barr) que causa linfocitosis, a menudo con linfocitos atípicos, y típicamente no cursa con esplenomegalia significativa ni con la presencia de promielocitos o blastos. d) Fiebre tifoídea: La fiebre tifoídea es una infección bacteriana que típicamente causa fiebre alta, malestar general y puede cursar con leucopenia o leucocitosis leve, pero no se asocia con la presencia de promielocitos o blastos en sangre periférica. e) Mielodisplasia: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo de neoplasias mieloides caracterizadas por hematopoyesis ineficaz y citopenias, con un riesgo de transformación a LMA. Si bien pueden haber displasias en las células mieloides y un aumento de blastos, el cuadro descrito con un 74% de promielocitos patológicos y 6% de blastos es mucho más compatible con una LMA establecida que con un SMD típico.

PREGUNTA 57 **Respuesta: C**

Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

1.08.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la **C (Leucemia mieloide aguda.)**. La clave aquí es la presencia de un alto porcentaje de blastos (75%) en el hemograma. En general, se considera que un porcentaje de blastos ≥20% en sangre periférica o médula ósea es suficiente para el diagnóstico de leucemia aguda, según los criterios de la OMS. La leucemia mieloide aguda (LMA) se caracteriza por la proliferación clonal descontrolada de precursores mieloides (blastos) en la médula ósea, lo que interfiere con la hematopoyesis normal y conduce a citopenias. El paciente de 30 años presenta cansancio (sintomático de anemia) y el hemograma reporta leucocitos en rango normal (4.800/microL) pero con el porcentaje de blastos muy elevado. Esto sugiere fuertemente la presencia de una LMA. Si bien el recuento de leucocitos puede estar elevado, normal o disminuido en la LMA, el hallazgo de >20% de blastos es diagnóstico. **Referencia:** Si bien no existe una guía clínica MINSAL específica para leucemia mieloide aguda, las guías internacionales y textos de hematología son consistentes con este criterio diagnóstico. La OMS es la principal autoridad en la clasificación de neoplasias hematológicas. Análisis de distractores: * **A: Anemia refractaria con exceso de blastos:** Esta es una forma de síndrome mielodisplásico (SMD). Los SMD suelen presentarse con citopenias (anemia, trombocitopenia, leucopenia) y un porcentaje de blastos elevado, pero generalmente menor al 20% en sangre periférica y hasta 30% en médula ósea. Aunque un SMD puede transformarse en LMA, el porcentaje de blastos en este caso es mucho más alto que lo esperado para un SMD. * **B: Leucemia linfática crónica:** Esta es una leucemia crónica que afecta a linfocitos maduros. En la LLC, el recuento de linfocitos está elevado y los blastos no son la característica principal. Además, es mucho más común en personas mayores. * **D: Leucemia mieloide crónica en fase crónica:** La LMC se caracteriza por la presencia del cromosoma Filadelfia (t(9;22)) y la proteína de fusión BCR-ABL. En la fase crónica, el recuento de leucocitos está elevado, pero el porcentaje de blastos es bajo (<5%). * **E: Leucemia mielomonocítica crónica:** Esta es una neoplasia mieloproliferativa/mielodisplásica crónica caracterizada por un aumento de monocitos en sangre periférica y displasia en una o más líneas celulares mieloides. Si bien puede haber blastos elevados, no suelen ser tan altos como en este caso (>20%).

PREGUNTA 58 **Respuesta: E**

Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

1.08.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Leucemias agudas.

PREGUNTA 59 **Respuesta: C**

Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

1.08.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La clínica es de leucemia aguda. En la práctica es imposible diferenciar una leucemia mieloide aguda de una linfática aguda solo por la clínica, pero las adenopatías y la edad (joven) sugieren más una leucemia linfática aguda.

PREGUNTA 60 **Respuesta: E**

Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)

1.08.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cuadro clásico

PREGUNTA 61 **Respuesta: C**

Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)

1.08.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La Leucemia Mieloide Crónica (LMC) es un trastorno clonal de la célula madre hematopoyética que se caracteriza por una proliferación excesiva de granulocitos y sus precursores inmaduros en la médula ósea y la sangre periférica. Se considera un síndrome mieloproliferativo clásico debido a su origen en las células mieloides y la tendencia a la proliferación descontrolada de estas líneas celulares. La LMC está fuertemente asociada con la presencia del cromosoma Filadelfia (Ph), resultado de una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 (t(9;22)(q34;q11)), que genera el gen de fusión BCR-ABL. Este gen codifica una proteína tirosina quinasa constitutivamente activa que impulsa la proliferación celular y la resistencia a la apoptosis. La LMC es un ejemplo prototípico de síndrome mieloproliferativo porque la alteración primaria reside en la médula ósea, afectando la producción de células mieloides. La proliferación desmedida de estas células conduce a un aumento significativo en el recuento de glóbulos blancos (leucocitosis), a menudo con un aumento de células inmaduras, así como a un aumento de plaquetas y, en ocasiones, de glóbulos rojos. A diferencia de otras neoplasias hematológicas, la LMC se caracteriza por una evolución generalmente indolente en su fase crónica, con progresión a fases acelerada y blástica si no se trata, lo que subraya su naturaleza mieloproliferativa. Análisis de distractores: a) Linfoma: El linfoma es un cáncer del sistema linfático, originado en los linfocitos, que son células del linaje linfoide. Los síndromes mieloproliferativos, por definición, afectan las células del linaje mieloide. b) Leucemia de células peludas: La leucemia de células peludas es una neoplasia linfoide rara, específicamente un tipo de leucemia de células B crónicas, y no un síndrome mieloproliferativo. d) Mielodisplasia: La mielodisplasia, o síndrome mielodisplásico, es un grupo de neoplasias mieloides en las que la médula ósea produce células sanguíneas anormales o inmaduras. A diferencia de los síndromes mieloproliferativos que se caracterizan por una proliferación descontrolada, en la mielodisplasia hay una ineficacia hematopoyética con citopenias y displasia (desarrollo anormal) de las células. e) Mieloptisis: La mieloptisis se refiere al reemplazo de la médula ósea normal por tejido fibroso, tumoral o granulomatoso, lo que lleva a una hematopoyesis ineficaz y a citopenias. Si bien puede ser secundaria a varias enfermedades, no es un síndrome mieloproliferativo primario.

PREGUNTA 62 **Respuesta: E**

Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)

1.08.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La leucemia mieloide crónica (LMC) se caracteriza clásicamente por la presencia del cromosoma Filadelfia (translocación t(9;22) que crea el gen de fusión BCR-ABL1), lo cual conduce a una tirosina quinasa constitutivamente activa. Este gen impulsa la proliferación descontrolada de células mieloides en la médula ósea, resultando en una leucocitosis (con predominio neutrofílico y desviación izquierda, indicando la presencia de precursores inmaduros), trombocitosis (aumento de plaquetas) y, en algunos casos, esplenomegalia. La presencia simultánea de estas tres alteraciones hematológicas apunta fuertemente a LMC, especialmente en ausencia de otras causas evidentes como infección severa. Si bien la médula ósea es la que otorga el diagnóstico definitivo, estos hallazgos periféricos son altamente sugestivos. Las guías clínicas del MINSAL para el manejo de leucemias resaltan la importancia de la sospecha diagnóstica temprana basada en hallazgos de laboratorio como estos para iniciar la evaluación y tratamiento oportuno. Análisis de distractores: * **A: Sepsis por bacterias Gram negativas:** La sepsis cursa con leucocitosis (o leucopenia en casos severos) y desviación izquierda, pero usualmente NO con trombocitosis. La trombocitopenia es más común en sepsis, especialmente si hay coagulación intravascular diseminada (CID). La etiología Gram negativa podría sugerirse con un shock séptico refractario a fluidos y vasopresores, sin embargo no es un hallazgo laboratorial directo. * **B: Reacción leucemoide:** Una reacción leucemoide es una elevación marcada de los leucocitos (generalmente >50.000/uL) con desviación izquierda, que puede simular una leucemia. Sin embargo, generalmente es causada por una infección severa, inflamación o estrés agudo. Si bien puede presentar trombocitosis, no es un hallazgo tan constante como en la LMC. Adicionalmente, una reacción leucemoide cesa una vez resuelta la causa subyacente, mientras que la LMC persiste y progresa sin tratamiento. * **C: Leucemia aguda promielocítica (LAP):** La LAP es un subtipo de leucemia mieloide aguda (LMA) caracterizada por la acumulación de promielocitos en la médula ósea. Se asocia frecuentemente con CID y trombocitopenia, no trombocitosis. La leucocitosis puede estar presente, pero no es un rasgo definitorio y puede incluso haber leucopenia. * **D: Leucemia aguda mielocítica (LMA):** La LMA, en general, también se caracteriza por la presencia de blastos en sangre periférica y médula ósea. Si bien puede haber leucocitosis, es más común encontrar citopenias (anemia, trombocitopenia). La trombocitosis no es una característica típica de la LMA, exceptuando algunos subtipos raros.

PREGUNTA 63 **Respuesta: B**

Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

1.08.1.011

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Linfoma de Hodgkin: La historia clínica sugiere un linfoma, probablemente de Hodgkin, por la presencia de síntomas B (fiebre, sudoración nocturna, malestar) y la edad. El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia ganglionar.

PREGUNTA 64 **Respuesta: A**

Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

1.08.1.011

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La afirmación falsa sobre los linfomas de bajo grado es que la tasa de recaídas después del tratamiento con quimioterapia suele ser muy baja. Si bien los linfomas de bajo grado a menudo responden bien inicialmente a la quimioterapia, son notoriamente conocidos por tener una alta tasa de recaída. El tratamiento puede inducir remisiones prolongadas, pero la enfermedad suele reaparecer con el tiempo. La quimioterapia en este contexto se utiliza más para controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida que para lograr una cura definitiva. Las opciones de tratamiento a menudo se centran en la vigilancia activa ("watchful waiting") hasta que la enfermedad provoque síntomas que requieran intervención. La razón principal por la que la opción A es incorrecta radica en la biología de estos linfomas. Suelen ser indolentes y de crecimiento lento, pero son difíciles de erradicar por completo con los regímenes de quimioterapia estándar. Las células tumorales residuales, a menudo presentes en la médula ósea o en otros tejidos linfoides, pueden volver a proliferar con el tiempo, lo que lleva a la recaída. Análisis de distractores: * **b) Al momento del diagnóstico suelen estar diseminados:** Esta es una característica común de los linfomas de bajo grado. Debido a su crecimiento lento y la falta de síntomas iniciales, a menudo se detectan en etapas avanzadas (III o IV) con afectación de múltiples ganglios linfáticos o incluso la médula ósea. * **c) Suelen presentar sobrevidas sobre los 10 años:** En general, la sobrevida de los pacientes con linfomas de bajo grado suele ser prolongada, a menudo superando los 10 años, especialmente con el manejo moderno y las opciones de tratamiento disponibles. Sin embargo, es crucial recordar que la enfermedad es incurable en la mayoría de los casos. * **d) En los adultos mayores, suelen observarse:** La incidencia de los linfomas de bajo grado aumenta con la edad, por lo que es más común observarlos en adultos mayores. * **e) Se diagnostican mediante biopsias ganglionares:** El diagnóstico definitivo de un linfoma requiere una biopsia del ganglio linfático afectado. La histología y la inmunohistoquímica son esenciales para determinar el tipo específico de linfoma y su grado.

PREGUNTA 65 **Respuesta: D**

Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

1.08.1.011

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La respuesta correcta es la (d) Translocaciones cromosómicas. Los linfomas, que son un grupo de cánceres que se originan en las células del sistema linfático (linfocitos), a menudo se caracterizan por la presencia de alteraciones genéticas específicas, siendo las translocaciones cromosómicas una de las más comunes y definitorias. Estas translocaciones implican el intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos, lo que puede dar lugar a la formación de genes de fusión oncogénicos o a la desregulación de genes clave en el crecimiento y la proliferación celular. Ejemplos clásicos incluyen la translocación t(8;14) en el linfoma de Burkitt, que une el gen MYC al promotor del gen de la inmunoglobulina, resultando en una sobreexpresión de MYC y una proliferación celular descontrolada. Estas alteraciones genéticas son fundamentales en la patogénesis de muchos tipos de linfoma, ya que pueden afectar vías de señalización celular importantes, interferir con la apoptosis (muerte celular programada) o promover la inestabilidad genómica. La identificación de translocaciones específicas es crucial para el diagnóstico, la clasificación y la elección del tratamiento en linfomas, ya que ciertas translocaciones están asociadas a pronósticos particulares y a la respuesta a terapias dirigidas. La naturaleza clonal de estas alteraciones subraya su papel en el origen maligno de estas neoplasias. Análisis de distractores: a) Mutaciones autosómicas dominantes: Si bien las mutaciones genéticas son importantes en el cáncer, los linfomas no se caracterizan predominantemente por mutaciones autosómicas dominantes como mecanismo principal de su origen. La mayoría de las mutaciones que conducen al cáncer son acumulativas y pueden afectar tanto a genes supresores de tumores como a oncogenes, y si bien algunas pueden ser dominantes, el patrón más distintivo en linfomas son las translocaciones. b) Mutaciones autosómicas recesivas: Las mutaciones recesivas generalmente requieren la inactivación de ambas copias de un gen para manifestar su efecto fenotípico. Si bien pueden ocurrir mutaciones recesivas en el desarrollo de linfomas, no son el tipo de alteración genética más definitoria o prevalente que impulse su iniciación y progresión. c) Mutaciones ligadas al sexo: Las mutaciones ligadas al sexo ocurren en los cromosomas sexuales (X o Y). Los linfomas afectan a ambos sexos, y aunque los cromosomas sexuales pueden ser el sitio de algunas alteraciones, la mayoría de las translocaciones o mutaciones significativas que impulsan el desarrollo de linfomas no están específicamente ligadas al sexo. e) Aneuploidías: Las aneuploidías son alteraciones en el número de cromosomas (por ejemplo, tener un cromosoma extra o faltar uno). Si bien las aneuploidías pueden estar presentes en algunos linfomas y contribuir a la inestabilidad genómica, no son el mecanismo genético primario que define el origen de la mayoría de los linfomas, a diferencia de las translocaciones cromosómicas que suelen ser eventos iniciadores y altamente característicos.

PREGUNTA 66 **Respuesta: C**

Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

1.08.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Era un mieloma múltiple, por cadenas ligeras peak monoclonal Kappa .

PREGUNTA 67 **Respuesta: C**

Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

1.08.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presentación clínica de un paciente de 65 años con dolores óseos, creatinina elevada (2.1 mg/dL), anemia (Hb: 9.7 g/dL) e hipercalcemia (11.1 mg/dL) es altamente sugestiva de Mieloma Múltiple. El Mieloma Múltiple es una neoplasia maligna de las células plasmáticas, caracterizada por la proliferación monoclonal de estas células en la médula ósea. La infiltración de la médula ósea por células plasmáticas anómalas puede desplazar a las células hematopoyéticas normales, llevando a anemia. Las lesiones líticas óseas, que causan los dolores óseos, son una manifestación clásica y son responsables de la liberación de calcio a la sangre, provocando hipercalcemia. Además, la disfunción renal observada en la creatinina elevada puede ser secundaria a la nefrotoxicidad por cadenas ligeras de inmunoglobulinas (proteinuria de Bence Jones), hipercalcemia severa o amiloidosis asociada. Análisis de distractores: a) Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo asociado: Si bien el paciente presenta insuficiencia renal y potencial hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal (que podría explicar la hipercalcemia), el dolor óseo difuso y la anemia marcada en este contexto son menos típicos de una IRC sin otra causa subyacente. La combinación de estos tres hallazgos es más específica de otra patología. b) Anemia de enfermedades crónicas: La anemia de enfermedades crónicas se caracteriza por ser normocítica, normocrómica y típicamente leve a moderada. Si bien puede coexistir con otras condiciones, no explica por sí sola la presencia de dolores óseos y una marcada hipercalcemia. d) Déficit de proteína C: El déficit de proteína C es un trastorno de la coagulación que predispone a eventos trombóticos, no a dolores óseos, anemia o hipercalcemia. e) Cáncer de próstata: El cáncer de próstata, especialmente en etapas avanzadas, puede metastatizar a hueso causando dolor y elevación de la fosfatasa alcalina. Sin embargo, la hipercalcemia y la anemia marcadas no son hallazgos tan prominentes ni característicos como en el Mieloma Múltiple, y la disfunción renal tampoco es una manifestación primaria típica, a menos que haya obstrucción o compromiso metastásico extenso.

PREGUNTA 68 **Respuesta: A**

Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

1.08.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la **a) Observar evolución**. El caso describe un Gamapatía Monoclonal de Significado Incierto (MGUS). MGUS se define por la presencia de una proteína monoclonal (proteína M) en suero u orina, menos del 10% de células plasmáticas clonales en la médula ósea y ausencia de daño orgánico asociado (CRAB: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, lesiones óseas) atribuible al trastorno de células plasmáticas. Dado que el paciente cumple con estos criterios y no presenta síntomas ni evidencia de mieloma múltiple o amiloidosis de cadenas ligeras relacionada, la conducta inicial apropiada es la observación periódica para detectar una posible progresión a mieloma múltiple u otra gamapatía maligna. El seguimiento generalmente implica la repetición de la electroforesis de proteínas y la evaluación de calcio, función renal, hemograma, y en ocasiones, biopsia de médula ósea, a intervalos regulares, dependiendo del riesgo de progresión. Análisis de distractores: b) **Indicar quimioterapia:** La quimioterapia no está indicada en MGUS, ya que no hay evidencia de mieloma múltiple activo u otra gamapatía maligna que requiera tratamiento. La quimioterapia se reserva para pacientes con mieloma múltiple sintomático o gamapatías relacionadas. c) **Iniciar ácido acetil salicílico:** El ácido acetil salicílico (aspirina) no tiene un papel en el tratamiento de MGUS. d) **Iniciar hidroxiurea:** La hidroxiurea se utiliza en algunos trastornos mieloproliferativos, pero no es un tratamiento para MGUS. e) **Realizar trasplante de médula ósea:** El trasplante de médula ósea es una opción de tratamiento para mieloma múltiple, pero no para MGUS, que es una condición premaligna asintomática.

PREGUNTA 69 **Respuesta: A**

Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

1.08.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Anemia, insuficiencia renal, dolores óseos. Es un mieloma.

PREGUNTA 70 **Respuesta: E**

Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

1.08.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una mielofibrosis clásica, sin embargo, toda mielofibrosis es a su vez una mielop- tisis. No debería haber un distractor correcto.

PREGUNTA 71 **Respuesta: C**

Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

1.08.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El cuadro clínico presentado, con un hematocrito elevado (62%), hemoglobina alta (20.6 g/dl), plaquetas aumentadas (500,000 por mm3), y la presencia de esplenomegalia, es altamente sugestivo de Policitemia Vera. La Policitemia Vera es una neoplasia mieloproliferativa crónica caracterizada por la proliferación clonal de precursores eritroides, pero que también afecta a las líneas granulocítica y megacariocítica, lo que explica el aumento en las plaquetas. La esplenomegalia es un hallazgo común debido a la extramedularidad de la hematopoyesis. El diagnóstico diferencial en un paciente con policitemia (aumento de glóbulos rojos) debe considerar causas primarias y secundarias. La Policitemia Vera se considera una causa primaria. En este caso, la combinación de policitemia, trombocitosis y esplenomegalia en un paciente sin otra patología aparente apunta fuertemente hacia esta condición, siendo la mutación JAK2 la más frecuente y un marcador diagnóstico clave. Análisis de distractores: a) Hemograma normal: Es incorrecto porque los valores de hematocrito y hemoglobina están significativamente elevados, indicando policitemia. b) Anemia por enfermedades crónicas: Es incorrecto, ya que esta condición se caracteriza por anemia (disminución de glóbulos rojos), no policitemia. d) Trombocitosis esencial: Es incorrecta. Si bien hay trombocitosis, la Trombocitosis Esencial se caracteriza principalmente por un aumento aislado de plaquetas, sin policitemia significativa ni esplenomegalia marcada como hallazgos centrales. e) Poliglobulia por hipoxemia: Es incorrecta. Si bien la hipoxemia puede causar policitemia secundaria (debido a un estímulo compensatorio por eritropoyetina), generalmente no se acompaña de trombocitosis ni esplenomegalia de esta magnitud, y suele haber una causa subyacente de hipoxemia (enfermedad pulmonar, cardíaca, etc.) que no se menciona en el caso.

PREGUNTA 72 **Respuesta: C**

Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

1.08.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En un paciente con policitemia vera de bajo riesgo, el objetivo principal del tratamiento es reducir la masa de glóbulos rojos para prevenir complicaciones trombóticas, que son el principal riesgo asociado a esta enfermedad. La sangría terapéutica, también conocida como flebotomía, es el método más directo y efectivo para disminuir rápidamente el hematocrito y la viscosidad sanguínea. La aspirina se administra de forma concomitante para reducir aún más el riesgo de eventos trombóticos, ya que la policitemia vera se asocia con un estado de hipercoagulabilidad. El enfoque en pacientes de bajo riesgo se centra en el control sintomático y la prevención de complicaciones a través de medidas más conservadoras y menos agresivas que en casos de alto riesgo. Análisis de distractores: a) Eritropoyetina subcutánea y aspirina: La eritropoyetina es un estimulador de la producción de glóbulos rojos, por lo que estaría contraindicada en un paciente con poliglobulia. Su uso podría empeorar la condición. b) Quimioterapia combinada y aspirina: La quimioterapia, como la hidroxiurea, se reserva para pacientes con policitemia vera de alto riesgo, quienes tienen un riesgo significativo de transformación a leucemia mieloide aguda o mielofibrosis, o presentan síntomas severos. En pacientes de bajo riesgo, es un tratamiento excesivo y conlleva riesgos de toxicidad innecesarios. d) Anticoagulación oral a permanencia: La anticoagulación oral no es el tratamiento de elección para la policitemia vera. Si bien el riesgo trombótico es elevado, la causa subyacente es la producción excesiva de glóbulos rojos, y la anticoagulación no aborda esta patología primaria. Además, podría aumentar el riesgo de hemorragias. e) Trasplante de médula ósea: El trasplante de médula ósea es un tratamiento curativo pero altamente agresivo, reservado para pacientes de alto riesgo con policitemia vera que no responden a otros tratamientos o que presentan transformación maligna. No es apropiado para un paciente de bajo riesgo.

BLOQUE 5 URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: C**

Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica

1.08.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 7). Evalúa el manejo clínico de Neutropenia febril según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 74 **Respuesta: A**

Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica

1.08.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presentación clínica del paciente, un niño de 5 años con exantema petequial y sangrado gingival después de una infección respiratoria reciente, sugiere fuertemente una trombocitopenia inmune (PTI) aguda. La PTI es una causa común de trombocitopenia en niños, a menudo precedida por una infección viral. Las petequias, el sangrado gingival y la ausencia de otros síntomas sistémicos apuntan a un problema primario con las plaquetas. El examen inicial y más importante es determinar si el paciente tiene trombocitopenia, lo que se logra mediante un hemograma con recuento de plaquetas. Un hemograma con recuento de plaquetas confirmará la presencia de trombocitopenia (recuento de plaquetas bajo). Una vez confirmada la trombocitopenia, se pueden considerar otras pruebas para descartar otras causas o evaluar la gravedad de la condición, pero el hemograma es el primer paso esencial para confirmar la sospecha diagnóstica. El contexto clínico apunta claramente a una etiología inmune post-infecciosa, por lo que la evaluación inicial debe enfocarse en confirmar la trombocitopenia. Análisis de distractores: b) Hemocultivos: Los hemocultivos se utilizan para detectar bacterias en la sangre, lo cual es relevante en casos de sepsis o infecciones sistémicas graves. En este caso, el paciente se encuentra afebril y en buenas condiciones generales, sin signos de infección activa grave que justifiquen la realización de hemocultivos. Si bien una infección pasada podría ser un factor desencadenante, la prueba directa no está indicada en este momento. c) Pruebas de agregación plaquetaria: Las pruebas de agregación plaquetaria evalúan la función de las plaquetas, pero son más útiles para investigar trastornos plaquetarios hereditarios o adquiridos que afectan la función plaquetaria, como la enfermedad de von Willebrand o el uso de antiagregantes plaquetarios. En este caso, la sospecha es de PTI, donde el problema principal es la disminución del número de plaquetas, no su función. d) Tiempo de sangría: El tiempo de sangría evalúa la función plaquetaria y la capacidad de formar un coágulo inicial. Aunque puede estar prolongado en la trombocitopenia, no es el examen inicial de elección para confirmar la sospecha diagnóstica, ya que es menos preciso y más invasivo que un simple recuento de plaquetas. Además, un tiempo de sangría prolongado podría deberse a otras causas aparte de la trombocitopenia. e) Tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial activada (TP/TTPa): TP y TTPa evalúan las vías de coagulación intrínseca y extrínseca, respectivamente. Están indicados en la evaluación de trastornos de la coagulación, como deficiencias de factores de coagulación o anticoagulantes. En este caso, la presentación clínica sugiere un problema plaquetario (PTI) y no un trastorno de la coagulación. Los tiempos de coagulación suelen ser normales en la PTI.

PREGUNTA 75 **Respuesta: E**

Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica

1.08.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La pregunta describe un escenario clínico común en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia: neutropenia febril. La neutropenia, una disminución significativa de neutrófilos en la sangre, compromete gravemente la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones bacterianas. La fiebre en este contexto es una señal de alarma que requiere intervención inmediata y empírica. *Pseudomonas aeruginosa* es un patógeno oportunista de alta virulencia y frecuentemente implicado en infecciones graves en pacientes neutropénicos, incluso en ausencia de un foco infeccioso aparente. Por lo tanto, el tratamiento empírico debe asegurar una cobertura antibiótica potente y de amplio espectro contra este bacilo gramnegativo. La combinación de Ceftazidina (una cefalosporina de tercera generación con excelente actividad contra *Pseudomonas aeruginosa*) y Amikacina (un aminoglucósido que también tiene una buena cobertura contra *Pseudomonas* y sinergia potencial con las cefalosporinas) proporciona una doble cobertura adecuada para abordar las infecciones bacterianas más probables y graves en este tipo de pacientes. Esta combinación ha sido históricamente recomendada y sigue siendo una opción sólida para el manejo empírico de la neutropenia febril, especialmente cuando se sospecha o se desea cubrir patógenos como *Pseudomonas*. Análisis de distractores: a) Ceftriaxona + gentamicina: Si bien la ceftriaxona es un antibiótico eficaz, su cobertura contra *Pseudomonas aeruginosa* no es tan robusta como la de la ceftazidima. La gentamicina es un aminoglucósido, pero la combinación de ceftriaxona con gentamicina puede ser insuficiente para garantizar una cobertura óptima contra *Pseudomonas* resistente o en situaciones de alta carga bacteriana. b) Piperacilina + vancomicina: La piperacilina es una penicilina antipseudomónica, lo cual es positivo. Sin embargo, la vancomicina está indicada principalmente para cubrir patógenos grampositivos, especialmente *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM) y *Enterococcus* resistentes a la vancomicina (ERV). Si bien puede ser necesaria en casos seleccionados de neutropenia febril (por ejemplo, si hay sospecha de catéter infectado o colonización por SARM), no aborda de manera directa la alta probabilidad de infecciones por bacilos gramnegativos como *Pseudomonas*. c) Ciprofloxacino + metronidazol: El ciprofloxacino es una fluoroquinolona con buena actividad contra *Pseudomonas*. Sin embargo, el metronidazol está diseñado para cubrir anaerobios y algunas bacterias atípicas. En el manejo empírico inicial de la neutropenia febril, no es el agente más adecuado para complementar la cobertura contra *Pseudomonas* y otros bacilos gramnegativos de importancia clínica. d) Levofloxacino + clindamicina: El levofloxacino es una fluoroquinolona con buena actividad antipseudomónica. Sin embargo, la clindamicina es un antibiótico que cubre grampositivos y anaerobios, pero su espectro no incluye a *Pseudomonas aeruginosa*. Esta combinación, aunque cubre algunos patógenos relevantes, no ofrece la doble cobertura específica y potente contra *Pseudomonas* requerida en este escenario.

PREGUNTA 76 **Respuesta: B**

Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

1.08.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una hipercalcemia por el mieloma. La primera medida es el suero fisiológico. Luego los bifosfonatos, para evitar que recurra. Solo si no funciona se administra calcitonina. Los corticoides sirven en la hipercalcemia por cáncer hematológicos, pero no son lo más importante.

PREGUNTA 77 **Respuesta: B**

Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

1.08.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Suero fisiológico endovenoso (hidratación agresiva)

PREGUNTA 78 **Respuesta: E**

Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

1.08.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Es un síndrome de lisis tumoral clásico, con rotura celular masiva, que se refleja en hiperuricemia, hiperkalemia, hiperfosfemia, hipocalcemia, acidosis, falla renal, compromiso de conciencia, compromiso hemodinámico. Se trata con hidratación, hipouricemiantes (ej. alopurinol) y manejo de los electrolitos según las alteraciones (ej. Bicarbonato, calcio, furosemida, insulina más glucosa, resinas de intercambio como el sulfonato de poliestireno, etc.).

PREGUNTA 79 **Respuesta: C**

Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

1.08.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la C) Quimioterapia combinada de inducción y luego de mantención. El tratamiento estándar de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en adultos y niños se basa en un régimen de quimioterapia intensiva que consta de varias fases. La fase de inducción tiene como objetivo lograr la remisión completa, es decir, erradicar la mayor cantidad posible de células leucémicas de la médula ósea. Posteriormente, la fase de consolidación (o intensificación) busca eliminar cualquier célula leucémica residual. Finalmente, la fase de mantenimiento, que puede durar varios años, se administra para prevenir la recaída de la enfermedad. Esta última fase es crucial para mantener la remisión a largo plazo, ya que la LLA tiene una alta tasa de recidiva si no se mantiene el tratamiento adecuado. La quimioterapia de inducción típicamente involucra una combinación de fármacos como vincristina, daunorrubicina (o doxorrubicina), asparaginasa y prednisona (o dexametasona). El tratamiento de mantenimiento generalmente incluye metotrexato y 6-mercaptopurina, administrados durante un período prolongado, junto con pulsos periódicos de otros fármacos. Este enfoque escalonado y combinado ha demostrado ser muy eficaz para mejorar las tasas de supervivencia en pacientes con LLA. La respuesta individual a la quimioterapia, la presencia de factores pronósticos adversos y la edad del paciente pueden influir en la elección de los fármacos específicos y la duración de cada fase del tratamiento. Análisis de distractores: * **A) Quimioterapia de inducción y radioterapia posterior a los huesos esponjosos:** La radioterapia a los huesos esponjosos no es una parte estándar del tratamiento de primera línea para la LLA, aunque puede utilizarse en casos específicos, como la afectación del sistema nervioso central (SNC) o la prevención de la recaída en el SNC. En la mayoría de los casos, la quimioterapia intratecal (administrada directamente en el líquido cefalorraquídeo) es preferible para tratar o prevenir la afectación del SNC. * **B) Trasplante de médula ósea:** El trasplante de médula ósea (o trasplante de células madre hematopoyéticas) no es el tratamiento de primera línea para todos los pacientes con LLA. Generalmente, se reserva para pacientes con enfermedad de alto riesgo o aquellos que recaen después de la quimioterapia inicial. El trasplante conlleva riesgos significativos y se realiza en centros especializados. * **D) Quimioterapia combinada de inducción sola:** Si bien la quimioterapia de inducción es esencial para lograr la remisión, no es suficiente por sí sola para tratar la LLA. Sin las fases de consolidación y mantenimiento, la probabilidad de recaída es muy alta. * **E) Exanguíneotransfusión y radioterapia:** La exanguíneotransfusión se utiliza principalmente en recién nacidos con problemas de incompatibilidad sanguínea o hiperbilirrubinemia grave, y no tiene un papel en el tratamiento de la LLA. La radioterapia, como se mencionó anteriormente, no es un componente estándar del tratamiento de primera línea.

PREGUNTA 80 **Respuesta: A**

Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

1.08.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La leucemia linfática aguda (LLA) en la infancia ha experimentado avances terapéuticos extraordinarios en las últimas décadas. Gracias a regímenes de quimioterapia intensificados, terapias dirigidas y un mejor manejo de las complicaciones, el pronóstico de supervivencia ha mejorado drásticamente. Actualmente, la tasa de supervivencia a 5 años para la LLA infantil se sitúa consistentemente por encima del 85%, y en algunos subgrupos de bajo riesgo, puede alcanzar incluso el 90% o más. Esta cifra representa un logro médico monumental, transformando la LLA de una enfermedad casi universalmente fatal a una patología con altas tasas de curación. Esta notable mejora se atribuye a una combinación de factores. La estratificación de riesgos basada en características clínicas y moleculares (como la citogenética y la presencia de marcadores específicos) permite adaptar los tratamientos a la agresividad individual de la enfermedad. Además, los protocolos de quimioterapia han evolucionado para ser más efectivos y, a su vez, se ha perfeccionado el soporte de soporte para manejar los efectos secundarios de estos tratamientos, como las infecciones y las toxicidades hematológicas. Análisis de distractores: b) 60%: Este porcentaje, aunque representa una mejora significativa sobre décadas pasadas, no refleja las tasas de supervivencia actuales. Estaría más acorde con el pronóstico de la LLA infantil en las décadas de 1970 o 1980, antes de los grandes avances terapéuticos. c) 30%: Esta tasa de supervivencia es demasiado baja para la LLA infantil actual y se asemeja más al pronóstico de otras leucemias o de la LLA en adultos sin tratamientos avanzados. d) 10%: Este porcentaje sería un pronóstico extremadamente sombrío, más propio de leucemias no tratadas o con complicaciones muy severas en épocas donde los tratamientos eran prácticamente inexistentes. e) 2%: Este valor es irrisorio y no representa en absoluto el pronóstico de la LLA infantil en la actualidad. Sería una tasa de mortalidad prácticamente del 100%.

PREGUNTA 81 **Respuesta: A**

Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

1.08.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Post quimioterapia: hiperuricemia + hiperkalemia + hiperfosfatemia + hipocalcemia + IRA = síndrome de lisis tumoral. Ocurre por destrucción masiva de células tumorales que liberan su contenido.

PREGUNTA 82 **Respuesta: E**

Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

1.08.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral)

PREGUNTA 83 **Respuesta: A**

Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

1.08.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Síndrome de compresión medular" como urgencia clínica (1.08.2.007), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 84 **Respuesta: C**

Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

1.08.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una trombofilia (A y C son compatibles). El TTPA alargado y el VDRL reactivo orientan mucho a un síndrome antifosfolípidos. El déficit de facor VIII produce hemofilia, por lo que tiene hemorragias, al igual que la EvW.

PREGUNTA 85 **Respuesta: B**

Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

1.08.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La deficiencia de antitrombina III (ATIII) es la trombofilia congénita más severa debido a que la ATIII es un inhibidor clave en la cascada de coagulación. Actúa inhibiendo la trombina y otros factores de la coagulación como el factor Xa. Su deficiencia, ya sea cuantitativa (tipo I) o cualitativa (tipo II), produce un estado de hipercoagulabilidad significativa y un alto riesgo de trombosis venosa y arterial, incluyendo trombosis a edades tempranas y en sitios inusuales. La ATIII tiene un rol crucial en la regulación de la coagulación, y su ausencia o mal funcionamiento deja la cascada sin un freno importante, llevando a una producción excesiva de trombina y formación de coágulos. La severidad de la deficiencia de ATIII radica en que, a diferencia de otras trombofilias, la ATIII inhibe múltiples factores de la coagulación, no solo uno específico. Las otras trombofilias, como la resistencia a la proteína C activada por el factor V de Leiden o las deficiencias de proteína C y S, afectan mecanismos reguladores más específicos. Aunque estas también incrementan el riesgo trombótico, el impacto global en la coagulación es menor comparado con la deficiencia de ATIII. La hiperhomocisteinemia, aunque relacionada con un mayor riesgo cardiovascular y trombótico, se considera una trombofilia menos severa y a menudo está asociada a otros factores de riesgo modificables. Análisis de distractores: a) **Factor V de Leiden:** Causa resistencia a la proteína C activada, lo que incrementa el riesgo de trombosis. Sin embargo, su impacto es menor que la deficiencia de ATIII, ya que afecta un solo punto de regulación. Muchos individuos con Factor V de Leiden son asintomáticos o desarrollan trombosis en circunstancias específicas. c) **Déficit de proteína C:** La proteína C es un anticoagulante natural que inactiva los factores V y VIII activados. Su deficiencia aumenta el riesgo de trombosis, pero no al nivel de la deficiencia de ATIII, ya que la ATIII inhibe una gama más amplia de factores de la coagulación. d) **Déficit de proteína S:** La proteína S actúa como cofactor de la proteína C, potenciando su acción anticoagulante. Su deficiencia, similar al déficit de proteína C, aumenta el riesgo de trombosis, pero es menos severa que la deficiencia de ATIII debido al alcance más limitado de su acción. e) **Hiperhomocisteinemia:** La hiperhomocisteinemia se asocia con un riesgo incrementado de trombosis, pero es menos severa que las deficiencias de los anticoagulantes naturales. Además, la hiperhomocisteinemia puede ser influenciada por factores nutricionales y, en algunos casos, puede ser tratada con suplementos vitamínicos.

PREGUNTA 86 **Respuesta: B**

Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

1.08.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La paciente presenta un cuadro clínico muy sugerente de una enfermedad autoinmune sistémica, específicamente Lupus Eritematoso Sistémico (LES) con una alta probabilidad de coexistencia o presentación primaria de Síndrome Antifosfolípido (SAF). Los datos clave que apuntan a esto son: 1. **Antecedente de esplenectomía por trombocitopenia:** Sugiere una púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una condición autoinmune que frecuentemente se asocia con LES. 2. **Cuatro abortos y un cuadro de trombosis venosa profunda:** Esta combinación de pérdidas recurrentes de embarazo y eventos trombóticos es patognomónica del Síndrome Antifosfolípido (SAF), una trombofilia adquirida que puede presentarse de forma primaria o secundaria a otras enfermedades autoinmunes como el LES. 3. **Síntomas sistémicos actuales:** Artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre son manifestaciones inespecíficas pero comunes de enfermedades autoinmunes sistémicas. Considerando estos antecedentes, las pruebas de laboratorio de mayor utilidad para llegar al diagnóstico son los Anticuerpos Antinucleares (ANA) como cribado para el LES y otras enfermedades del tejido conectivo, y los Anticuerpos Anticardiolipina para confirmar el Síndrome Antifosfolípido, dada la fuerte sospecha clínica. El ANA es positivo en más del 95% de los pacientes con LES, lo que lo convierte en una excelente prueba de tamizaje. Los anticuerpos anticardiolipina son uno de los principales criterios de laboratorio para el diagnóstico del SAF. Análisis de distractores: * **a) Factor reumatoide y anticuerpos antinucleares (ANA):** ANA es relevante, pero el Factor Reumatoide se asocia principalmente con la Artritis Reumatoide, una condición que no explica tan bien la historia de abortos recurrentes y trombosis. * **c) Factor reumatoide y anticuerpo enfermedad de Lyme:** El Factor Reumatoide no es el marcador principal aquí. No hay elementos clínicos que sugieran la enfermedad de Lyme (e.g., exposición a garrapatas, eritema migratorio). * **d) Anticuerpo anti-ADN nativo y anti-Ro (SSA):** Si bien estos son anticuerpos específicos de LES (anti-ADN nativo es muy específico y anti-Ro se asocia a subtipos específicos de LES y Sjögren), son pruebas de confirmación. El ANA es una mejor prueba de *tamizaje inicial* y, fundamentalmente, esta opción omite la búsqueda de anticuerpos para el Síndrome Antifosfolípido (anticardiolipina), que es crucial dada la clínica. * **e) Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCAs) y antihistonas:** Los ANCAs son marcadores de vasculitis, que no es la presentación predominante aquí. Los anticuerpos antihistonas se asocian principalmente con el lupus inducido por fármacos, para lo cual no hay datos en la anamnesis.

PREGUNTA 87 **Respuesta: C**

Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

1.08.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es otro síndrome antifosfolípidos, por la misma razón del TTPA alargado (mayor a 40).

PREGUNTA 88 **Respuesta: A**

Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas

1.08.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Reacción leucemoide" (1.08.1.014), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 89 **Respuesta: C**

Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas

1.08.3.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Un paciente con grupo sanguíneo AB posee antígenos A y B en la superficie de sus glóbulos rojos y no tiene anticuerpos anti-A ni anti-B en su plasma. Por lo tanto, puede recibir glóbulos rojos de cualquier grupo sanguíneo (A, B, AB u O) sin riesgo de una reacción hemolítica por incompatibilidad ABO clásica. Recibir sangre de un grupo diferente al suyo no provocará que sus anticuerpos ataquen a los glóbulos rojos transfundidos, ya que no tiene tales anticuerpos. El grupo O, al carecer de antígenos A y B, no será atacado por ningún anticuerpo anti-A o anti-B. Los grupos A y B, al poseer el antígeno correspondiente, tampoco serán atacados ya que el paciente AB no posee anticuerpos anti-A ni anti-B. Finalmente, el grupo AB es compatible por definición. Por lo tanto, un paciente AB es considerado el "receptor universal" en el sistema ABO. Análisis de distractores: * **a) Sólo AB:** Esta opción es incorrecta porque el paciente AB puede recibir otros grupos sanguíneos además del AB, debido a la ausencia de anticuerpos anti-A y anti-B. * **b) AB, A y B:** Esta opción es incorrecta porque no incluye el grupo O, el cual también es compatible debido a que carece de antígenos A y B, siendo seguro para cualquier grupo sanguíneo. * **d) O y AB:** Esta opción es incorrecta porque no incluye los grupos A y B, que también son compatibles con el grupo AB. * **e) A y B:** Esta opción es incorrecta porque no incluye los grupos O y AB, que también son compatibles con el grupo AB.

PREGUNTA 90 **Respuesta: A**

Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas

1.08.3.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La reacción hemolítica transfusional en este caso es altamente probable y severa debido a la incompatibilidad ABO. Una persona con grupo sanguíneo A tiene antígeno A en sus glóbulos rojos y anticuerpos anti-B en su plasma. Al recibir glóbulos rojos AB, el receptor A reconocerá el antígeno B presente en los glóbulos rojos transfundidos como extraño. Esto desencadenará una respuesta inmune inmediata, donde los anticuerpos anti-B del receptor se unirán a los glóbulos rojos AB donados, causando su aglutinación y posterior hemólisis intravascular. La hemólisis masiva libera hemoglobina en el torrente sanguíneo, lo que puede resultar en complicaciones graves como insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada (CID), shock e incluso la muerte. La gravedad y rapidez de la reacción son características de la incompatibilidad ABO, por lo que la probabilidad de una reacción hemolítica transfusional significativa es extremadamente alta, cercana o superior al 95%. Análisis de distractores: * **b) 65%-95%:** Aunque una reacción es muy probable, esta opción subestima la virtual certeza de la misma dada la incompatibilidad ABO completa. La respuesta inmune es predecible y rápida. * **c) 35%-65%:** Esta probabilidad es demasiado baja considerando la incompatibilidad ABO. Las reacciones hemolíticas transfusionales debidas a incompatibilidad ABO son casi siempre severas. * **d) 5%-35%:** Esta probabilidad es mucho menor a la que se esperaría. Este rango podría aplicar a incompatibilidades menores del sistema Rh u otros antígenos, pero no para ABO. * **e) Menor al 5%:** Esta probabilidad es extremadamente improbable. La incompatibilidad ABO resulta en una reacción hemolítica masiva en la gran mayoría de los casos.
